

КРАТКАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Не просто накормить

Как организовать безопасное, достойное и вариативное питание людей с психическими нарушениями в домах социального обслуживания



Евгений Владимирович Чистяков

директор СПб ГАСУСО «Дом социального обслуживания „Серафимовский“»

По материалам межрегионального семинара-совещания «Пространство Новых Идей 2.0»,
Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года

Содержание

- | | |
|---|---|
| 1. Зачем: один обед, пять конфликтов | 6. Документы, проверяющий и ответственность директора |
| 2. Что такое вариативное меню и где на лестнице стоит ваш дом | 7. Сколько это стоит и как это измерять |
| 3. Что разрешено и чем это подтверждается | 8. Учредитель и возражения |
| 4. Граница с клиникой: что кухня не назначает | 9. Что сделать в понедельник |
| 5. Пилот на девяносто дней | Источники |

Как читать

Эта версия написана для директора и учредителя, у которых есть один вечер, а не неделя. Она не пересказывает полный том по главам, а отвечает на восемь вопросов в том порядке, в каком их задают на планёрке и в кабинете учредителя: зачем всё это, что представляет собой вариативное меню, что разрешено законом и чем это подтверждается, где проходит граница с клиникой, как устроен пилот на девяносто дней, какие документы нужны и что говорить проверяющему, сколько это стоит и как это измерять, что сказать учредителю и как отвечать на возражения. В конце дан список действий на первый понедельник.

Все числа, нормы и цитаты взяты из полного тома второй редакции и снабжены теми же маркерами источников в двойных фигурных скобках; расшифровка маркеров — в разделе 44 полного тома. Каждое утверждение относится к одному из четырёх классов: норма, толкование, рекомендация или проект локальной формы. При пересказе класс не повышается: толкование остаётся толкованием, зарубежное число остаётся зарубежным. Каждый раздел заканчивается отсылкой к разделам полного тома, где тема изложена полностью, с источниками и оговорками.

Если времени совсем нет, прочитайте разделы 1, 4 и 9: зачем, чего кухня не делает никогда и с чего начать в понедельник.

Класс	Что это	Пример из доклада
Норма	Прямое требование действующего акта	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, п. 56: питание не менее трёх раз в день, суточные пробы (раздел 32.2)
Толкование	Вывод из нормы или из сочетания норм	Обязанность предложить альтернативу при отказе выводится из ст. 5, 37 и 43 закона № 3185-1 (разделы 17, 32.3)
Рекомендация	Предложение автора, основанное на данных или опыте; зарубежный перенос — ориентир	Пилот на 90 дней; ориентир Онтарิโอ «не более двух полностью кормимых на одного помогающего» (разделы 20.3, 35)
Проект локальной формы	Образец документа: дом может принять, но не обязан; адаптирует и утверждает сам	Приложения 1–45, например матрица ролей (приложение 17)

Класс не повышается при пересказе

Толкование не становится нормой оттого, что повторено несколько раз, а зарубежное число не становится российским фактом без оговорки о переносимости.

Четыре категории доступности источника — не смешивать под словом «верифицировано» (раздел 41.2)

публичный первоисточник	внутренний документ
вторичная публикация	требует перепроверки

Для сравнения: по шкале приказа Минздрава № 103н основания вариативного меню в лучшем случае соответствуют уровням достоверности 3–5 — это оценка автора, а не формальная процедура: доклад — не клиническая рекомендация.

Рисунок 1. Четыре класса утверждений: на чём стоит каждая фраза доклада и почему класс не повышается при пересказе (разделы 41.1–41.2)[1]

1

Зачем: один обед, пять конфликтов

Обед, как он есть

Разговор о вариативном меню стоит начинать не с витрины, а с обычного обеда. Средний российский психоневрологический интернат, по расчёту аналитического проекта «Если быть точным», рассчитан на 289 мест; по тем же данным, в 2024 году в России работали 466 взрослых ПНИ, где жили 139 тысяч человек[2]. Это вторичная аналитика, а не ведомственная статистика, но ясно главное: за один обед кормят больше сотни людей.

Собирательная сцена из полного тома выглядит так. Зал на сто двадцать мест, раздача в три захода, на линии по одному варианту каждого блюда. В первом заходе двенадцать жителей едят только с чужой помощью, а на смене четыре сиделки, одна из которых в это время разносит лекарства. За этот час за столом сталкиваются пять конфликтов.

Первый — **очередь против помощи**. Самостоятельных обслуживают первыми, потому что так быстрее, а тех, кого кормят, обслуживают в три цикла, и последние едят холодное. Порядок расхождения между «покормили» и «помогли поесть» показывает американское контролируемое исследование: помощь по протоколу требовала в среднем 42 минуты на человека за один приём пищи против примерно пяти минут при обычной практике, и именно протокольная помощь удерживала массу тела у жителей с риском похудения[3]. Это американские дома ухода, и норматива для России из этих минут не выводится; но разница в разы покрывается скоростью, а скорость за столом — главный механизм вреда.

Второй — **«он опять не ест кашу»**. Житель третий день отодвигает тарелку, журнала отказов нет, и врач узнает о происходящем на обходе в четверг. За отказом может стоять депрессия, а может начинающаяся дисфагия; покашливание за столом никто с ним не связывает.

Третий — **лекарства и кофе**. Житель на клозапине выпил с утра две большие кружки кофе, принесённого родственниками, и никто не предупредил семью, что кофеин повышает концентрацию препарата[4].

Четвёртый — **добавка**. Житель на оланзапине за год прибавил четырнадцать килограммов и просит вторую котлету; сиделка отказывает по собственному представлению о пользе, а не по назначению врача. Антипсихотики различаются по прибавке веса в разы: по метаанализу ста рандомизированных исследований — от -0,23 до +3,01 кг за шесть недель[5]. Вечером этот житель забирает хлеб у соседа, и эпизод разбирают как нарушение дисциплины, а не как самовольное ограничение рациона, с которого всё началось.

Пятый, самый опасный, — **журналы «в порядок»**. К приходу комиссии учредителя суточные пробы за прошедшие дни подписывают задним числом. Этот конфликт подменяет контроль его имитацией, а типовой состав дел по статье 6.6 КоАП против социальных учреждений — как раз отсутствие суточных проб и недоброкачественные продукты[6].

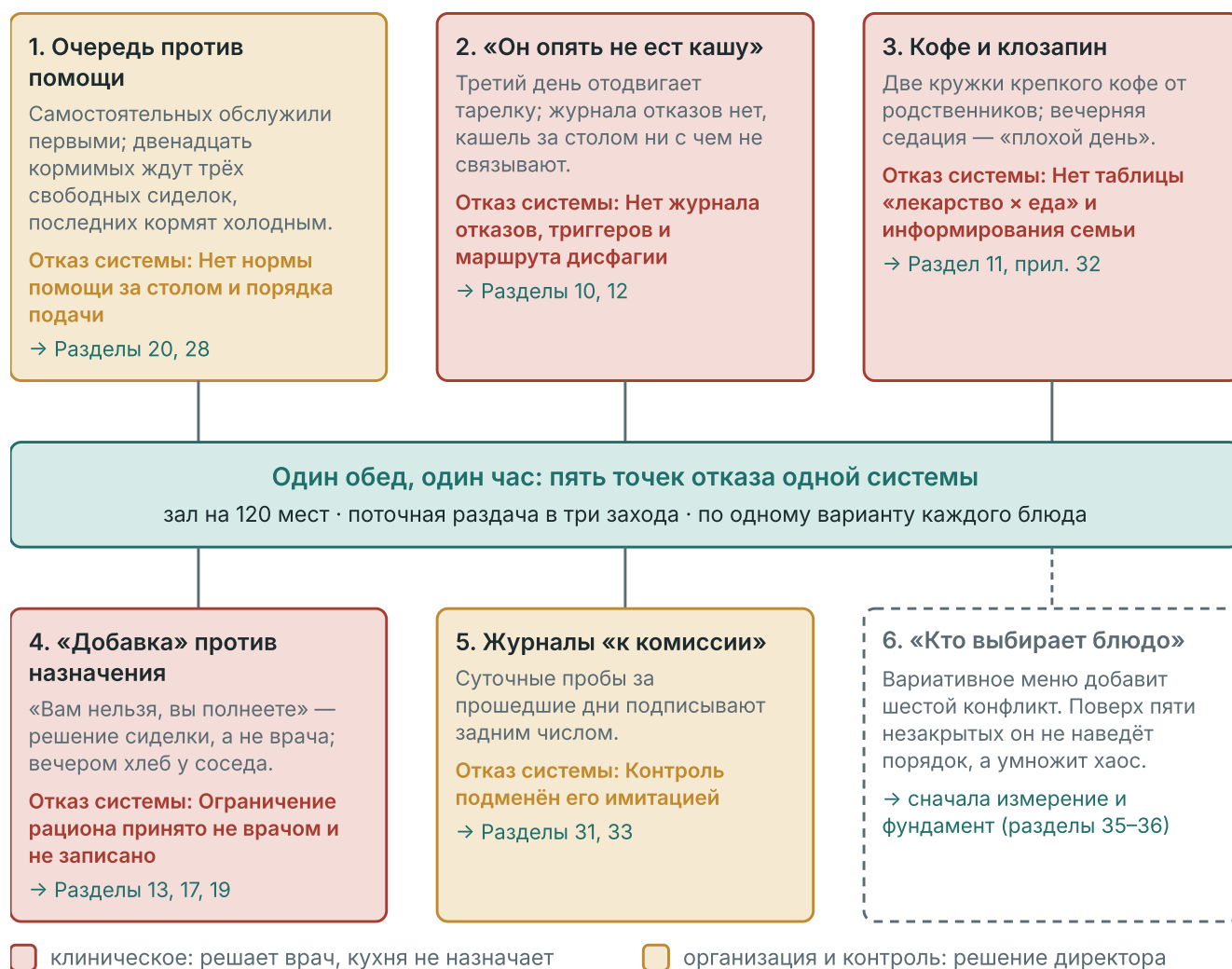


Рисунок 2. Один обед — пять точек отказа одной системы; шестой конфликт, «кто выбирает блюдо», появляется вместе с вариативным меню (раздел 5.2). Параметры зала — по [7].

Почему это одна система, а не пять проступков

У каждого эпизода есть очевидный виновник: медлительная сиделка, капризный житель, неосведомлённая семья, несдержанный едок, нерадивый завхоз. Выговор каждому ничего не изменит: через неделю всё повторится. Перед нами пять точек отказа одной системы, в которой нет нормы помощи за столом и порядка подачи, нет журнала отказов и маршрута дисфагии, нет лекарственно-пищевой таблицы, ограничения рациона вводятся не врачом, а контроль имитируется.

Справка. Системный подход к ошибке. В науке о безопасности — медицинской, авиационной, промышленной — различают индивидуальный и системный взгляд на ошибку. Первый ищет виновного; второй спрашивает, какие условия сделали ошибку вероятной и почему её ничто не остановило. Повторяющийся сбой в одном и том же месте почти всегда указывает на устройство процесса, а не на характер исполнителя. Если последних кормят холодным каждый день, проблема не в сиделке, а в порядке подачи и численности смены.

Для начала ни один из пяти конфликтов не требует денег: нужны решение директора и документы. Три из пяти упираются в кадровую нагрузку, и здесь честнее сразу назвать дефицит, чем делать вид, что его закроет приказ. Важно и другое: вариативное меню добавляет шестой конфликт — «кто выбирает блюдо». Если пять базовых конфликтов не закрыты, шестой добьёт систему, потому что выбор, наложенный на хаос, только умножает хаос. Поэтому разумный порядок действий начинается не с витрины, а с измерения и фундамента.

Скрытая цена стола

Риски стола не только бытовые. Расстройства глотания в изученных группах пациентов, получающих антипсихотики, встречаются у 21,9–69,5 % человек[8], среди проживающих зарубежных домов ухода — примерно у 47 %[9]. Смертность от пневмонии при тяжёлых психических расстройствах в семь раз выше популяционной[10], смертность от удушья пищей при шизофрении — в двадцать раз[11]. Ни один из этих диапазонов нельзя переносить на российские дома как готовую распространённость: исследований с валидированными инструментами в наших ДСО и ПНИ нет. Но и нижние границы говорят о массовой проблеме, а не об исключении. Организация стола входит в профилактику преждевременной смертности.

Есть и деньги. Голодный житель и оплаченное сырьё, которое уходит в бак, — не две проблемы, а одна. Национальной доли пищевых отходов в наших домах не существует; получить её можно только одним способом — семидневным замером, а не лозунгом.

Наконец, права. По данным за 2022 год, обработанным проектом «Если быть точным», порядка трёх из четырёх жителей ПНИ признаны судом недееспособными[2]. В вашем доме доля может быть другой, но логика от этого не меняется: для человека, который живёт в интернате, еда — три-четыре события в день, и нередко главные события дня. Права, записанные в законе, за столом либо доходят до тарелки, либо остаются строкой.

Как выглядит та же столовая через год

Мужчина на клозапине пьёт кофе в количестве, согласованном с врачом, и семья знает почему. Житель с дисфагией получает свою текстуру, и тарелка у него не выглядит «детской». Неговорящий житель показал на карточку и получил то, на что показал. Журналы пишутся в тот день, о котором в них сказано. Конфликты не исчезли, но каждый получил процедуру и перестал зависеть от настроения дежурной.

Подробно: разделы 2, 5, 6, 43 полного тома.

2

Что такое вариативное меню и где на лестнице стоит ваш дом

Четыре понятия, которые путают

В разговорах о выборе обычно смешивают четыре разные вещи. **Цикличное меню** — повторяющийся цикл блюд: четырнадцать дней в российских раскладках, двадцать один день в Онтарио, четыре недели по немецкому стандарту[7, 12, 13]. Оно даёт разнообразие во времени, но не выбор: каждый день все получают одно и то же. **Замена по таблице** — эквивалентная замена продуктов в раскладке, которая десятилетиями присутствует в нормах питания[14, 15]; её применяет кухня по остаткам и поставкам, а не житель. **Персонализация** — индивидуальные назначения врача: текстура, ограничения, усиленное питание. И только **вариативное меню** означает, что в одной точке приёма пищи существует больше одного варианта и житель выбирает.

Полный том держит строгое определение: **в момент еды житель реально может получить не менее двух вариантов и сам влияет на то, какой из них получит**. Заказ накануне этим определением не исключается, если заказанное действительно доходит до тарелки, а резерв в каждом варианте позволяет передумавшему у линии получить то, что он выбрал сегодня.

Лестница моделей М0–М5

Между мономеню и полным выбором лежат шесть рабочих конфигураций, каждая со своей ценой и своими рисками.

- **М0. Мономеню с учётом отказов.** Выбора нет, но отказ от блюда влечёт замену по таблице, и житель не остаётся голодным. Это фундамент, а не вариативность; американская федеральная норма требует такой альтернативы сходной питательной ценности как базового минимума[16].
- **М1. Выбор из двух в одной позиции** на части приёмов пищи и в часть дней. Так начинал Болотнинский ПНИ: несколько раз в неделю, на завтрак и обед, перечень блюд определяет диетическая сестра[17]. Усть-Илимский дом вводил выбор поэтапно, предварительно опросив жителей[18].
- **М2. Выбор по всем основным позициям ежедневно.** По публикациям, так работает Успенский ПНИ во всех отделениях: два вторых, два салата, два напитка[19]. В Иркутской области выбор из двух первых, двух вторых и гарниров описан для одного отделения Марковского геронтологического центра с сентября 2024 года; единой региональной модели нет, четыре учреждения области работают по-разному[20].
- **М3. Выбор на линии раздачи**, близкий к «шведскому столу». Требуется площади, скорости потока и санитарного контроля открытых блюд; для ПНИ применим выборочно.

- **M4. Семейная подача за столом.** Блюда ставят в общей посуде, жители накладывают сами; применяется точно.
- **M5. «Своя кухня».** Жители готовят при поддержке персонала; для российского дома это горизонт тренировочных квартир, а не массовая модель.

Подтверждённые российские практики стоят на ступенях M1–M2[17, 18, 19, 20]. Это сообщения самих учреждений, а не независимый аудит, и полный том разбирает, что о них известно и чего мы не знаем.

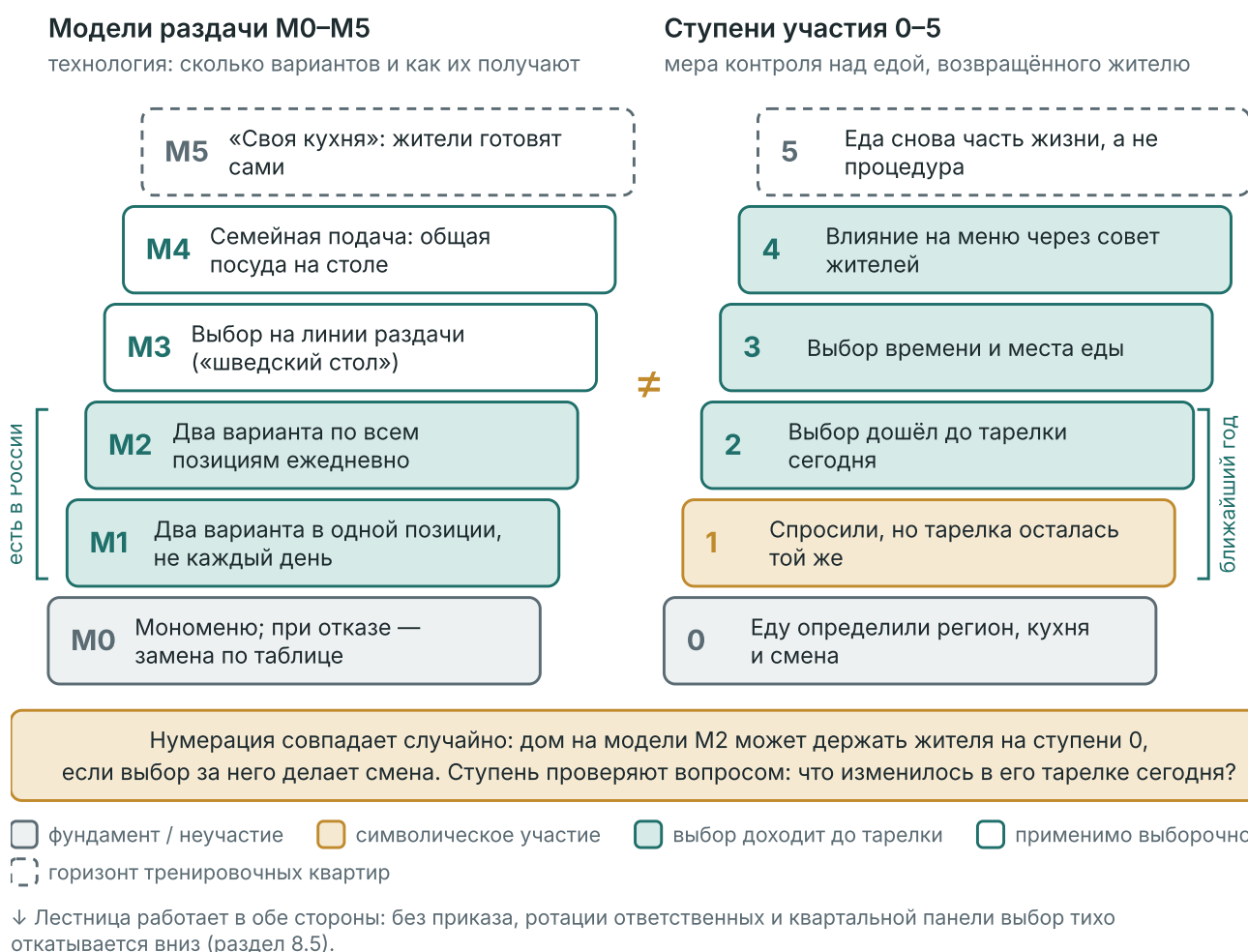


Рисунок 3. Две лестницы с одинаковой нумерацией и разными осями: модели раздачи (раздел 8.2) и ступени участия жителя (раздел 8.6). Модели M1–M2 описаны в сообщениях российских учреждений[17, 18, 19, 20].

Справка. Модель и степень участия. Модель (M0–M5) описывает технологию раздачи: сколько вариантов, где и как житель их получает. Степень участия (0–5) описывает, сколько контроля над едой возвращено конкретному человеку: от «еду определили регион, кухня и смена» через «выбор дошёл до тарелки сегодня» до «еда снова стала частью жизни». Дом может работать по модели M2 и держать многих жителей на нулевой ступени, если выбор за них делает смена. Нумерация совпадает случайно; оси разные. Образ лестницы участия заимствован у Шерри Арнстайн, писавшей о гражданском участии[21]: участие измеряется не тем, спросили ли человека, а тем, изменило ли его слово результат.

Пять критериев реального выбора

Любую модель проверяют пятью критериями. **Доступность:** вариант Б существует, когда к раздаче подходит житель, а не закончился на первом отделении. **Равноценность:** варианты эквивалентны по питательной ценности, то есть подобраны по таблице замен, а не по принципу «гречка или ничего». **Информированность:** житель знает о выборе и понимает его доступным ему способом — словом, показом порций, визуальным меню. **Уважение:** выбранное подаётся, а ограничения вправе устанавливать только врач. **Учёт:** выбор записывается и влияет на завтрашние объёмы.

Австралийское исследование домов престарелых показало, насколько велик разрыв между меню на бумаге и выбором на тарелке: в наблюдаемых трапезах выбора в обед не было ни для одной группы, а группа на изменённых текстурах теряла выбор первой[22].

Самооценка за пятнадцать минут и тихий регресс

Самооценка почти всегда завышена. Поэтому ступень и модель определяют не по положению, а по трём вопросам о вчерашнем дне: покажите вчерашний журнал; был ли второй вариант вчера физически на линии; кто вчера выбрал не то, что принесли бы по умолчанию. Если на третий вопрос третью неделю отвечают «таких нет», выбор декоративен. Правило для обеих осей одно: **оценка — это вчерашний день, а не положение.**

Лестница работает в обе стороны, и вниз по ней движутся чаще, чем вверх. Уходит инициатор, показ меню «временно» упрощают, через квартал журнал ведётся «для проверки», и выбор снова делает кухня. Снаружи учреждение по-прежнему «внедрило» вариативность. Противоядие — опора на документ и ритм, а не на человека: приказ, ротация ответственных, квартальная панель. Практику, пережившую смену двух заведующих, можно считать устоявшейся; до этого рубежа она остаётся проектом энтузиаста.

У выбора есть и смысл за пределами столовой: на постоянном сопровождаемом проживании, по вторичной аналитике, живут не более 1,8 тысячи человек, а большинство получателей таких услуг учится самостоятельной жизни в квартирах на базе ПНИ[2]. Человек, который десятилетиями не выбирал даже кашу, встречает магазин и плиту как чужой язык; выбор внутри дома тренирует этот навык. На ближайший год для большинства домов реалистичны ступени участия 1–2.

Подробно: разделы 8, 19, 25 полного тома.

3

Что разрешено и чем это подтверждается

Короткий ответ

Федеральное право не запрещает вариативность и не обязывает давать выбор каждого блюда. Закон требует кормить достаточно, безопасно и с уважением; он не требует кормить одинаково. Но директору этого мало: проверяющему нужна бумага, которая разрешает выбор именно в его доме. Поэтому ответом на вопрос «а нам можно?» служит не формула «запрета нет», а комплект документов (раздел 6 этой версии).

Справка. Классы утверждений. Норма — цитата закона или подзаконного акта с реквизитами и датой проверки; ею спорят с юристом и проверяющим. **Толкование** — системное прочтение нормы применительно к ситуации, которую сама норма прямо не регулирует; оно разумно, но может быть оспорено. **Рекомендация** — опыт конкретного учреждения или вывод исследования: «делайте так, потому что так сделали там-то», но не императив. **Проект локальной формы** — шаблон приказа, положения или журнала, который требует локальной правовой проверки. Чаще всего дому вредит одна ошибка: принять толкование за норму. Тогда либо запрещают разрешённое, либо требуют того, чего закон не требует.

Три зоны права

Полный том раскладывает право на три зоны.

Зелёная зона — то, что разрешено или прямо требуется. Санитарные правила требуют организовать питание проживающих не менее трёх раз в день, в том числе диетическое (лечебное) по медицинским показаниям; с 1 сентября 2026 года это пункт 56, подпункт 11 СанПиН 2.3/2.4.4282-26, который заменил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 без переходного периода[23]. Ни одна из двух редакций не ограничивает число вариантов блюд. Закон № 442-ФЗ даёт получателю услуг право на уважительное и гуманное отношение и на участие в составлении индивидуальной программы; эта программа для получателя носит рекомендательный характер, а для поставщика обязательна[24]. Закон № 3185-1 в части 2 статьи 5 гарантирует «уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение человеческого достоинства»; статья 43 распространяет на проживающих ПНИ права из частей 2 и 4 статьи 37, включая право соблюдать религиозные каноны, в том числе пост[25]. Приказ Минтруда № 520н задаёт рекомендуемые нормы питания[26], а таблицы замены в региональных нормах — действующий механизм эквивалентной замены и тем самым легальная основа пар блюд[14, 15].

Жёлтая зона — то, что делать можно, но только через документ: назначение врача, локальный акт, основание обработки данных. Ограничение рациона, изменение текстуры, пищевые карты, совет жителей с полномочиями по меню, сама вариативность — всё это законно, когда у особенности, касающейся человека, есть автор, основание и срок. Ограничение без назначения — не диета, а произвол, пусть и доброжелательный.

Красная зона — нарушения независимо от намерений. Лишение еды или питья как мера воздействия нарушает часть 2 статьи 5 Закона № 3185-1[25]; для всех домов ту же границу проводит статья 25, пункт «f», Конвенции о правах инвалидов, запрещающая дискриминационный отказ в пище или жидкостях[27]. Насилие при кормлении недопустимо. Суточные пробы «задним числом», журналы по памяти и недоброкачественные продукты — состав статьи 6.6 КоАП[6]. Систематический отказ в питании «за опоздание» нарушает требование о питании не реже трёх раз в день — это толкование, но прямое[23]. **Число блюд в красную зону не входит.**

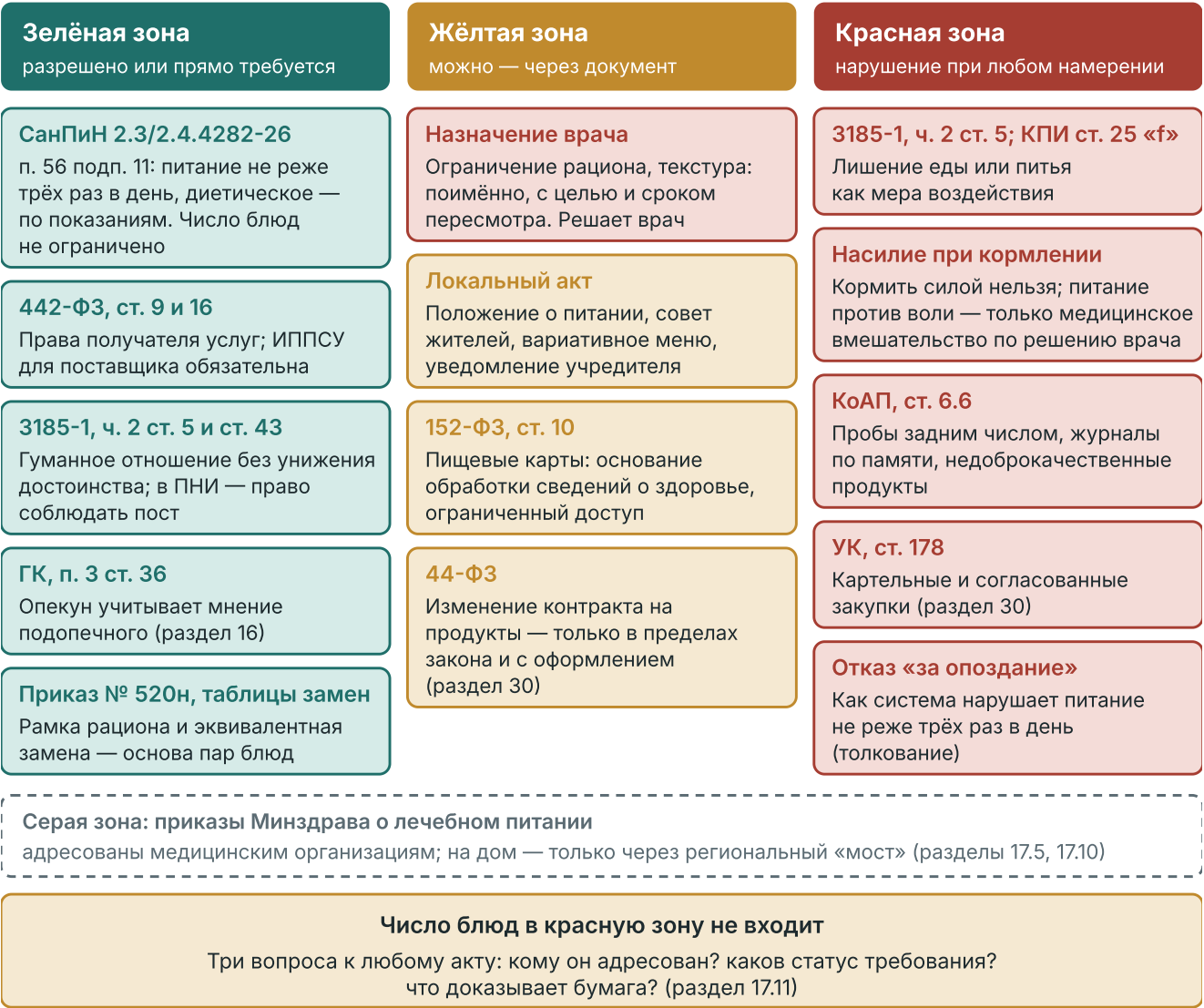


Рисунок 4. Карта норм: что разрешено прямо, что — через процедуру, что запрещено независимо от намерений; число блюд в красную зону не входит (разделы 17.2–17.4)[6, 23, 24, 25]

Что разрешено и чем это подтвердить

Что делает дом	Класс утверждения	Чем подтвердить при проверке
Два варианта блюда внутри норм питания	Норма о нормах и заменах; вариативность — рекомендация на основе практики[14, 17, 19]	Меню с парами эквивалентов и обоснованием равноценности, положение о питании

Что делает дом	Класс утверждения	Чем подтвердить при проверке
Замена блюда при отказе	В России — толкование из ч. 2 ст. 5 и ст. 43 Закона № 3185-1[25]	Журнал замен с датой, альтернативой и отметкой, принял ли житель замену
Ограничение рациона (сахар, соль, порция)	Жёлтая зона: только по назначению	Назначение врача поимённо, с целью и сроком пересмотра
Изменение текстуры	Жёлтая зона: клиническая необходимость	Назначение врача, список дисфагического риска, маркировка порций
Пищевые карты со сведениями о здоровье	Норма: специальная категория данных, ч. 2 ст. 10 152-ФЗ[28]	Основание обработки, ограниченный круг доступа; кухне — функция, а не диагноз
Пищевые предпочтения в индивидуальной программе	Норма: программа обязательна для поставщика[24]	Запись в ИППСУ, пищевая карта
Пилот на одном отделении	Рекомендация	Приказ о пилоте, уведомление учредителя, журналы, панель показателей

Недееспособность не отменяет выбора

Сделки за недееспособного совершает опекун (статья 29 ГК РФ), но повседневное пищевое предпочтение, как правило, сделкой не является. Опекун обязан выяснять и учитывать мнение подопечного (пункт 3 статьи 36 ГК РФ). С тем, кто не говорит, работают четыре канала воли: показ (жест, взгляд, карточка), наблюдение за тем, что человек ест и что оставляет, пищевая биография и знание близких. Там, где молчит и наблюдение, остаётся стандартный вариант: выбирать, чтобы поесть, не обязательно. Позиция доклада о приоритете зафиксированной воли и о случаях, когда учреждение само является опекуном, аргументирована, но остаётся позицией и требует правовой проверки в локальном акте.

Серая зона лечебного питания и важные различия

Приказы Минздрава о лечебном питании, в том числе приказ от 05.08.2003 № 330, адресованы медицинским организациям и на организации социального обслуживания автоматически не распространяются[29, 30]. В некоторых регионах есть «мост» — распоряжение, прямо связывающее соцучреждения с системой диет; пример — распоряжение 19РВ-32 Московской области, на которое опирается ДДСОЛ[7]. Если моста нет, работает временная конструкция: назначения по питанию даёт врач письменно, кухня исполняет их через текстуры и исключения продуктов, а не через «номерные диеты», учредителю ежегодно направляется предложение о региональном акте.

Права жителей ПНИ и ДСО общего профиля не совпадают. Статья 43 Закона № 3185-1 распространяется на организации, предназначенные для лиц с психическими расстройствами, то есть на ПНИ; в ДСО опорой служат 442-ФЗ и Конвенция о правах инвалидов. Ссылка на Конвенцию о правах инвалидов в положении — обоснование, а не источник обязанности: формула «Конвенция требует двух вариантов каши» была бы повышением класса.

Что доклад не знает

Репрезентативной статистики вариативного питания в российских организациях нет. Рандомизированных исследований эффекта вариативности в психиатрических стационарах не найдено, и это не особенность психиатрии: систематический обзор EDWINA по мерам поддержки

питания при деменции, включивший 56 вмешательств из 51 исследования, не нашёл окончательных доказательств эффективности конкретных мер^[31]. Судебной практики о вариативном меню не обнаружено, статус норм в каждом регионе индивидуально не проверен, а нормы и учётные формы меняются, поэтому перед изданием приказа их сверяют заново. Пробелы — не слабость, а карта мест, где читатель включает собственную проверку.

Подробно: разделы 16, 17, 18, 24, 41 полного тома.

4

Граница с клиникой: что кухня не назначает

Граница, которую произносят первой

Эту границу нужно назвать раньше любого перечня взаимодействий, иначе предложение о вариативном питании будет услышано как медицинская реформа руками повара.

Только с врачом: любые ограничения рациона, включая «диабетический стол»; изменение текстур; правила при дисфагии и протокол свободной воды; действия при длительном отказе от еды; режим питания при седации; решения о зондовом питании и о комфортном кормлении в конце жизни; сдвиг времени еды у жителей на инсулине; слабительные и реакция на запор; анализы и добавки микронутриентов; интерпретация скрининга недостаточности питания.

Только с учредителем: изменение продуктовой строки финансирования; изменение штатного расписания, в том числе нормы помощи за столом; аутсорсинг питания; официальный статус пилота и его публичность.

Только после правовой проверки: формулировки о «согласии недееспособного» в локальных актах; обработка пищевых карт как персональных данных; ответы на запросы прокуратуры; конструкции, в которых учреждение одновременно выступает опекуном жителя.

Врач

решает клинику

- ограничения рациона, в том числе «диабетический стол»
- текстуры, правила при дисфагии, протокол свободной воды
- действия при длительном отказе от еды
- питание при седации; время еды на инсулине
- зонд и комфортное кормление в конце жизни
- анализы, добавки, скрининг MUST
- подписывает таблицу «лекарство × еда»

Кухня и администрация

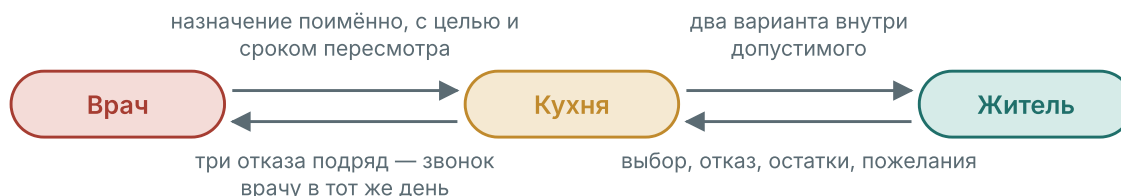
исполняют и организуют

- исполняют назначение и таблицу врача, не ставят диагноз
- два варианта блюда внутри допустимого
- журналы проб, бракеража, отказов, заказа — в ритме смены
- замер отходов и ночного интервала
- еда не подаётся, пока помощь не готова

Житель

выбирает

- блюдо из того, что допустимо по назначению врача
- повседневное пищевое предпочтение, как правило, не сделка: недееспособность не отменяет выбора
- говорит словом, жестом, отказом, остатками на тарелке



Только с учредителем: финансирование продуктовой строки, штаты и норма помощи за столом, аутсорсинг питания, статус пилота

Только после правовой проверки: «согласие недееспособного» в локальных актах, пищевые карты как персональные данные, ответы прокуратуре

Рисунок 5. Граница раздела 4.0: врач задаёт множество допустимых блюд, кухня исполняет и организует, житель выбирает внутри этого множества. Клинику кухня не назначает.

Дисфагия: невидимая угроза

Справка. Дисфагия и аспирация. Дисфагией называют любое затруднение при продвижении пищи или жидкости изо рта в желудок. В домах социального обслуживания преобладает ротоглоточная дисфагия, когда нарушен сам акт глотания. Её главная опасность — аспирация, то есть попадание пищи, жидкости или слюны в дыхательные пути. Аспирация бывает «немой»: человек не кашляет, и приём пищи внешне выглядит благополучным. Отсутствие кашля ещё не говорит о безопасности.

Механизмы дисфагии в наших домах действуют одновременно: побочные эффекты и седация от антипсихотиков, сама болезнь, торопливая еда, возраст, неврологические болезни, плохие зубы и протезы. Риск удушья повышают именно сильные антагонисты дофаминовых рецепторов в высоких дозах[11]; выбор препарата — решение врача, но дом должен знать, что смена схемы лечения меняет и риск за столом.

Распознавание начинается не со специалиста, а с обученного наблюдателя. Тревожные признаки видит и сиделка без логопеда: кашель и поперхивание во время еды и после неё, «влажный» голос после глотка, многократное проглатывание одного куска, еда за щекой, необычно долгий приём пищи, отказ от твёрдого при сохранном аппетите, повторные пневмонии. Любой признак — повод записать наблюдение и сообщить врачу.

Дом без логопеда может своими силами выстроить организационный минимум из семи элементов: список риска на посту и на кухне; назначенные врачом поимённо текстуры с датой пересмотра; вертикальная поза, малые порции и тридцать минут сидя после еды; приём таблеток по тем же правилам; осторожность с хлебом, сухими продуктами, крупными кусками и блюдами смешанной консистенции; алгоритм удушья и двое обученных сотрудников на посту в часы еды; передача сведений о риске при каждом переводе и госпитализации. Этот пакет не лечит и не заменяет врача; он переводит дом из состояния «не знаем, кто в группе риска» в состояние «знаем, наблюдаем, исполняем назначения».

Справка. IDDSI. Международная инициатива по стандартизации диет при дисфагии описывает восемь уровней консистенции: для напитков 0–4, для пищи 3–7; существует официальный русский перевод терминов. Каждую консистенцию можно проверить подручными средствами: напиток — тестом на текучесть из шприца, пищу — надавливанием вилкой и наклоном ложки. IDDSI — язык и метод проверки, а не диагностика: уровень назначает медицинский специалист.

Общий язык текстур даёт измеримый результат. В исследовании пяти учреждений доля поданных текстур, совпадающих с назначенными, выросла после внедрения IDDSI с 44 до 90 %, для загущённых жидкостей — с 31 до 100 %, и главным барьером оказалась осведомлённость персонала, а не оборудование^[32]. Решающее вложение — обучение, а не закупка техники.

Дисфагия не отменяет выбор: она переносит его внутрь текстуры. Вместо одного протёртого второго жителю предлагают два варианта той же консистенции. Без этого группа с дисфагией теряет одновременно и здоровье, и голос.

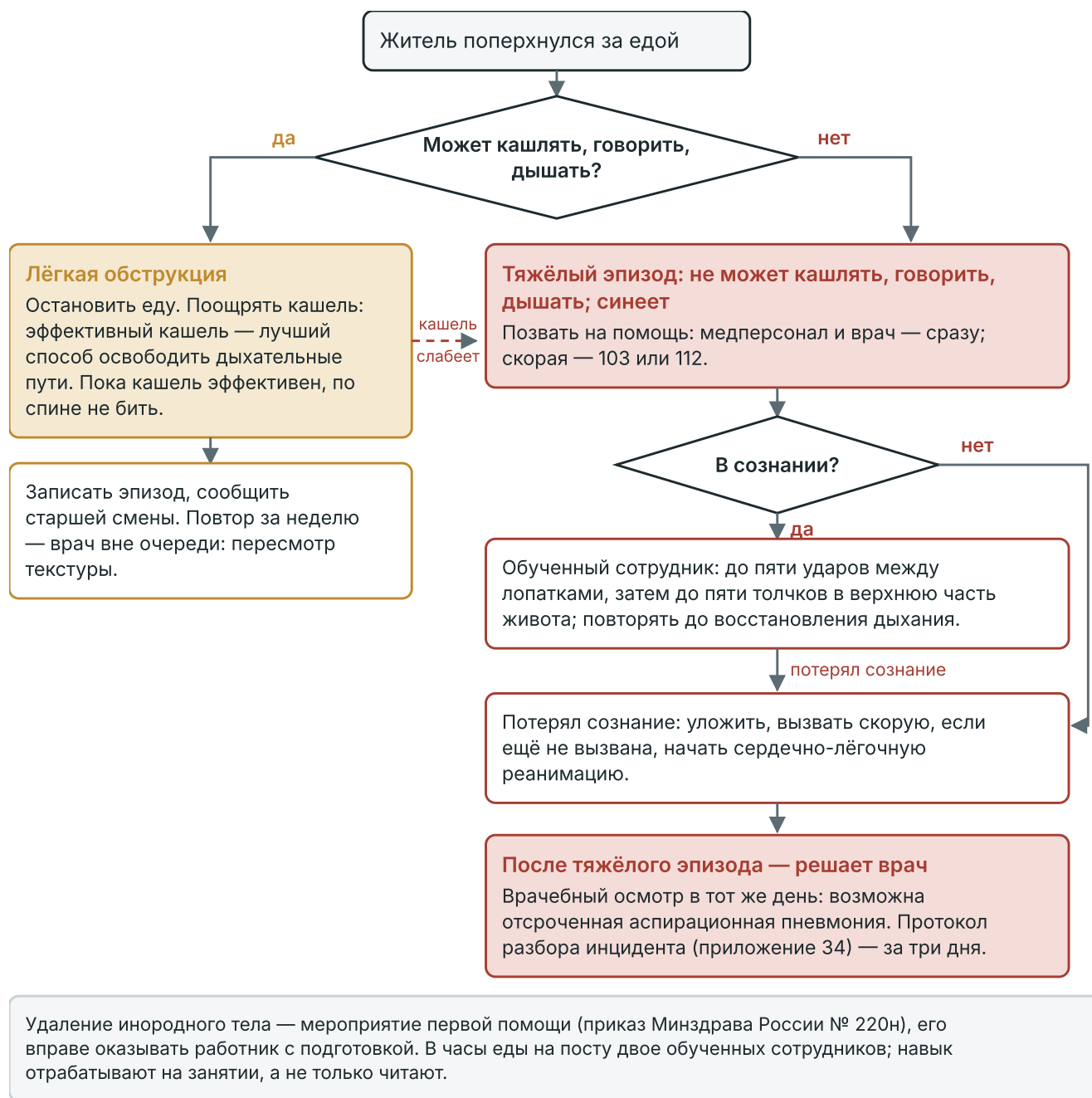


Рисунок 6. Алгоритм приложения 12 в виде схемы для поста: по алгоритму Совета по реанимации Великобритании[33] и порядку оказания первой помощи[34]. Схема не заменяет практического занятия.

Четыре лекарственно-пищевых правила

Взаимодействий «препарат — пища» десятки, но столу нужен не справочник, а короткий перечень с действиями для кухни и поста. Четыре правила кухня исполняет по таблице врача[4, 35, 36, 37].

Клозапин и кофеин. Кофеин тормозит разрушение клозапина: в контролируемом исследовании добавка 400–1000 мг кофеина в сутки повышала площадь под фармакокинетической кривой в среднем на 19 %[4], а резкая отмена привычного кофеина снижает концентрацию на 37–47 %[38]. Курение ускоряет разрушение препарата, поэтому вынужденный отказ от курения при поступлении или болезни тоже повод сообщить врачу. Кофе не служит ни наградой, ни наказанием; резкие изменения привычки без врача не допускаются.

Литий, соль и вода. Литий выводится почками тем же путём, что и натрий: резкое уменьшение соли или обезвоживание повышают его концентрацию, резкое увеличение соли ослабляет лечение[35]. Кухня не вводит «малосольный стол» без врача, вода стоит на виду, о рвоте, поносе, лихорадке у жителя на литии врач узнаёт в тот же день.

Ингибиторы МАО и тирамин. При приёме неселективных ингибиторов МАО тирамин из выдержанных сыров, копчёностей, солений вызывает гипертонический криз[36]. Жёсткость тираминовой разметки для конкретного препарата определяет врач; выбор строится внутри безопасного множества.

Грейпфрут. Грейпфрут тормозит фермент, разрушающий карбамазепин и ряд других препаратов, и повышает их концентрацию; для карбамазепина — порядка 40 %[37]. Решение простое: грейпфрута и его сока нет ни в закупке, ни в меню, «подарочные» соки в передачах проверяет дежурный.

Таблица «лекарство × еда» на посту законна только с подписью врача и пересматривается при каждой смене терапии. На кухню и в комнату передач уходит не диагноз и не название препарата, а результат: «без грейпфрута», «кофе — не больше привычного». Регламент передач пишется как разрешение с перечнем недопустимого, а не как полный запрет: полный запрет порождает подполье, и кофе всё равно попадает к жителю, но уже без учёта.

Отказ от еды: алгоритм вместо интуиции

За одним и тем же «не буду» может стоять невкусное блюдо, депрессия, бред отравления, дисфагия, зубная боль или угасание в конце жизни. Цена ошибки несимметрична: пропущенный «каприз» стоит тарелки, пропущенная дисфагия или депрессия может стоить жизни. Главная ошибка — смешение причин: осознанный отказ лечат как симптом, а симптом списывают на характер. Первое унижает человека, второе может его убить.

Полный том предлагает **проект российского правила**, построенный по образцу канадских профессиональных рекомендаций[39]; это не российская норма, и в локальном акте он должен быть так и обозначен. Каждый отказ записывается и влечёт альтернативу в тот же приём. **Три отказа подряд — врач в тот же день**, а не на обходе в четверг. Если человек неделю системно оставляет четверть порции и больше — врач и пересмотр карты в течение двух дней. Отказ от воды или одновременно от еды и воды — немедленно. Эпизод закрывается записью о том, что установлено и когда пересмотр.

Граница для смены не допускает толкований: жителю **предлагают, заменяют, адаптируют, фиксируют, эскалируют — силой не вводят**. Искусственное питание — медицинское вмешательство, решение о котором принимает врач в порядке, установленном законом. В корпусе есть расхождение о том, запрещено ли принудительное кормление прямой нормой или запрет выводится из права на достоинство; для смены разницы нет — сила исключена.

Вес, ночь и помощь за столом

Ограничение порции «потому что полнеет» без назначения врача — самовольное ограничение рациона; работа с весом идёт через врача. Ночной интервал между ужином и завтраком — операционная цель дома не больше тринадцати часов; это рабочий ориентир авторов внутри международного диапазона 11–14 часов, а не нормативное требование. Если интервал больше, сдвигают расписание или по согласованию с врачом вводят вечерний перекус. Наконец, помощь за столом: международная норма Онтарио допускает не более двух полностью кормимых жителей на одного работника и требует подавать еду, только когда помощь готова[12]. В России такой нормы нет, а рекомендуемые нормативы приказа Минтруда № 305н дают одну должность помощника по уходу на 12 получателей в смену для самых зависимых групп[40]. Ни одна российская норма не описывает час еды отдельно, и значит, этот час дом организует сам: все свободные руки на время еды, рассадка по степени помощи, подача под готовые руки, а дефицит — числом и письменно учредителю.

Подробно: разделы 4.0, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 28 полного тома.

5

Пилот на девяносто дней

Почему пилот и почему девяносто дней

Призыв «меняйте всё с понедельника» ломает сразу две вещи: кухню, которая работает как поток с жёстким ритмом, и самих жителей, для которых предсказуемость среды — часть благополучия. Пилот бережёт и то и другое: меняется одна точка, всё остальное идёт как вчера.

Справка. Пилот осуществимости. В методологии различают исследование осуществимости, которое отвечает на вопрос «можно ли это сделать в наших условиях и какой ценой», и исследование эффективности, которое отвечает на вопрос «приносит ли это пользу». Первому не нужны контрольная группа и большая выборка, второму нужны. Теория внедрения называет результаты первого типа исходами внедрения: приемлемость, принятие, уместность, осуществимость, точность исполнения, стоимость, охват и устойчивость[41]. Вмешательство может не сработать потому, что оно неэффективно, а может — потому, что хорошее вмешательство исполнено неправильно; первое называют провалом вмешательства, второе — провалом внедрения.

За девяносто дней проявляются три вещи: устойчивая статистика выбора, когда схлынул эффект новизны; реальные трудовые издержки, когда смена перестаёт работать «на подъёме»; первые конфликты, без которых не бывает ни одной перемены. Российский опыт подтверждает логику постепенности: Усть-Илимская организация шла от опроса предпочтений к расширению практики[18], а Успенский ПНИ зафиксировал, что страхи персонала не подтвердились, — но сделал этот вывод после пробного периода, а не до него[19].

Точка пилота

Одно отделение на 20–35 жителей, одна смена-единомышленница, один приём пищи. Меньше — это проба, больше — реформа без подстраховки. При выборе отделения «сложный» контингент — группа помощи, неговорящие жители — предпочтительнее удобного: практика, прошедшая сложное отделение, масштабируется почти сама, а прошедшая только удобное ломается о первое сложное и хоронит тему для всего дома.

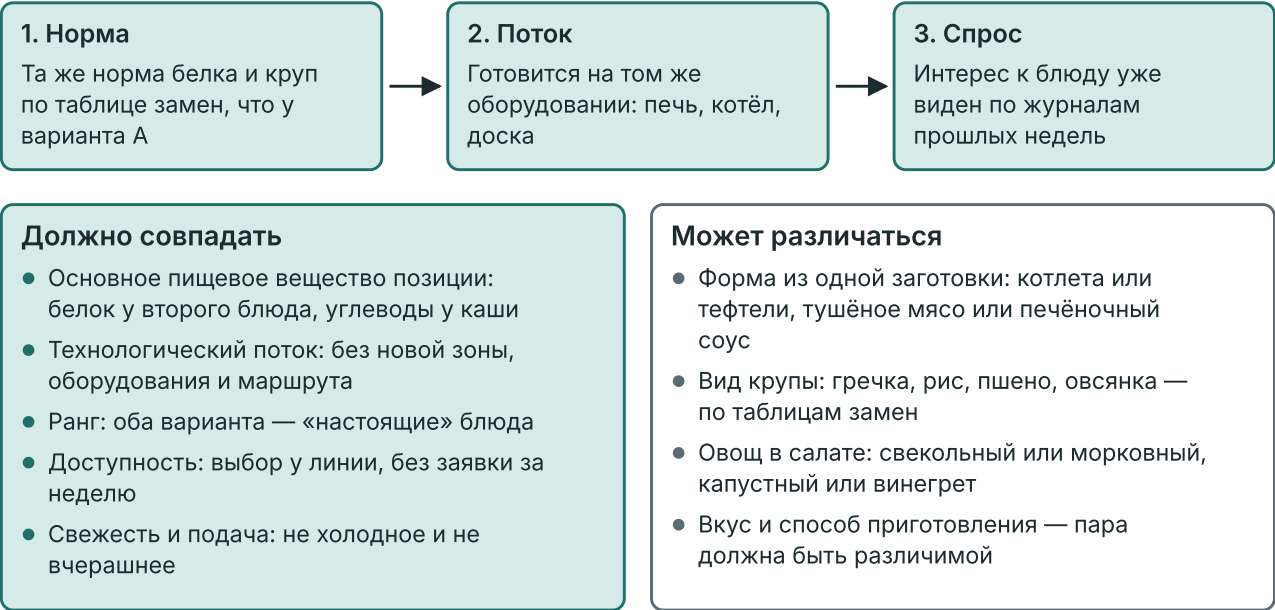
Технология двух вариантов без второй кухни

Модель М1 требует не второй кухни, а второго варианта ключевого блюда в том же технологическом потоке: каши А и Б варятся одновременно в двух котлах, вторые блюда А и Б готовятся из одной мясной заготовки двумя способами. Вариант Б проходит три фильтра: норма (та же норма белка или круп по таблице замен), поток (то же оборудование), спрос (интерес, видный по журналам). Рабочие пары просты: гречка, рис, пшено, овсянка; котлета или тефтели;

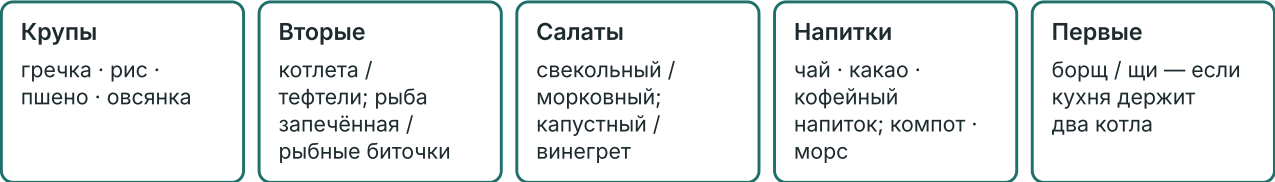
рыба запечённая или рыбные биточки; свекольный или морковный салат. Пара должна быть различимой и одного «ранга»: «рыба или остатки вчерашнего» сортирует жителей по сортам, и они считают это сразу.

Объёмы планируются по обычной тетради. Вчерашний выбор задаёт сегодняшнюю варку; пока статистики нет, готовят пятьдесят на пятьдесят с резервом; раз в две недели доля выбравших вариант Б корректирует закупку. Главный индикатор сбоя — доля тех, кто выбрал вариант Б и не получил его; она должна стремиться к нулю, а если растёт, виноваты объёмы, а не «непредсказуемые жители». Журнал замен — недооценённый документ: только он доказывает, что отказ обернулся альтернативой, а не голодом.

Вариант Б становится парой варианту А, только если проходит три фильтра (раздел 19.2)



Рабочие пары, проверенные практикой



Какао и кофейный напиток — кофеиновая строка пищевой карты
Кофеин влияет на концентрацию клозапина (раздел 11): кому их можно, решает врач. Клинику кухня не назначает.

Что не является парой (раздел 19.9)

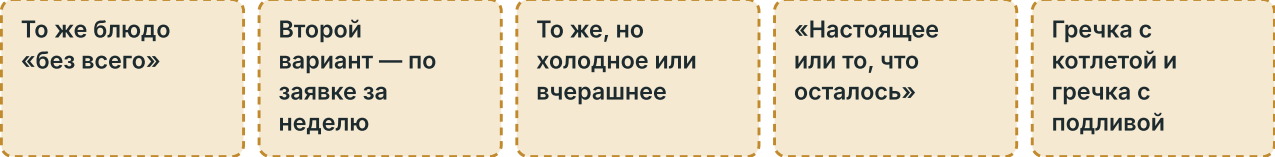


Рисунок 7. Пара эквивалентов: три фильтра для варианта Б, что в паре должно совпадать и что может различаться, рабочие пары и мнимые пары (разделы 19.2 и 19.9)[14, 15]

Три этапа

Дни 1–14: подготовка без изменений на линии. В первую неделю подписывается приказ о пилоте: точка, сроки, ответственные, критерии успеха и остановки, дата решения по итогам. Одновременно начинается замер «до»: семь дней учёта отходов, времени раздачи и отказов. Семь дней, а не один, потому что единичный «показательный» день почти всегда нетипичен. Во вторую неделю в точке пилота проводится опрос предпочтений, ответы заносятся в пищевые карты, смена раздачи проходит инструктаж, учредитель получает письмо, а папка для проверяющего собирается до старта.

Дни 15–75: работа. Минимальная конфигурация — два варианта второго блюда на обед, два-три дня в неделю, заказ вечером накануне или прямо на линии. **Стандартный вариант гарантирован всегда**, даже если житель ничего не выбрал. Журналы заказа и замен ведутся с первого дня. Раз в неделю — пятнадцатиминутная планёрка, где замечания раскладываются по трём корзинам: смена (очередь, маркировка), кухня (пары, объёмы), администрация (документы, закупка). Третья корзина не должна пустовать дольше двух недель: если администрация ничего не делает, смена видит, что её усилия никому не нужны, и пилот выдыхается.

Дни 76–90: оценка и решение. Двенадцать показателей панели сравниваются «после» и «до», и ни одно число не показывают без фразы «что это значит». Совет жителей заслушивает итоги, протокол прикладывается к отчёту учредителю. Решение директора — одно из трёх, на бумаге: расширение, закрепление точки или свёртывание с причинами.

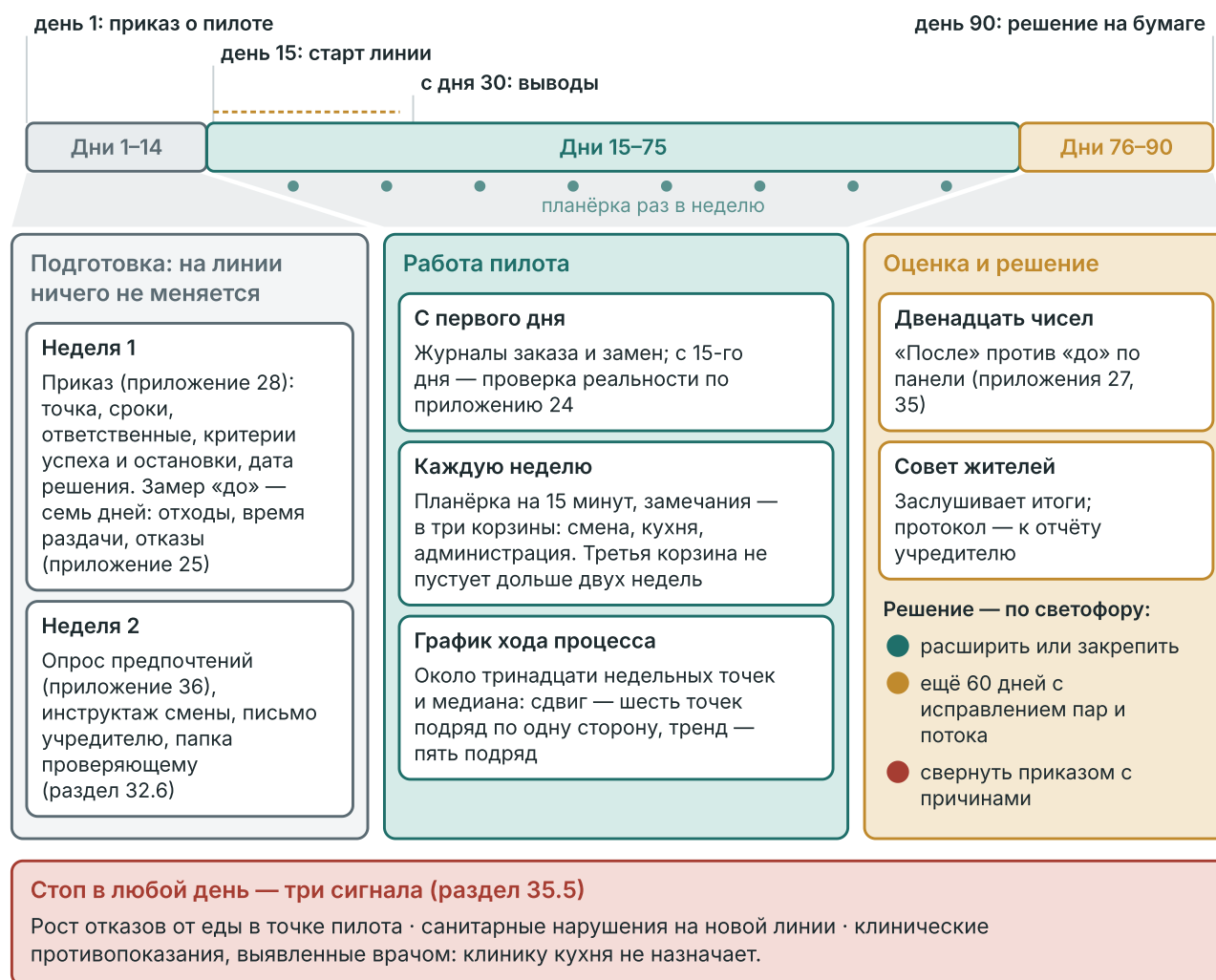
Первая неделя работы линии по дням

День	Что происходит	На что смотреть
День 1	Накануне вечером объявлено меню и собран заказ; утром до варки сверены объёмы; на линии старшая смены	Вечером — десятиминутный разбор
Дни 2–3	Обычные сбои: очередь у варианта Б, забытые бирки, «стандартные» порции без вопроса	Каждый сбой исправляется вечером того же дня
Дни 4–5	Учёт срывов и замен	Проверка реальности выбора: пять вопросов приложения 24
Выходные	Линия может не работать в режиме выбора	Журнал не молчит: записывается, что выдано
День 7	Планёрка	Замечания по трём корзинам: смена, кухня, администрация

До того как накопятся семь дней данных, ничего не отменяется и не «улучшается»: первая неделя — базовая линия новой схемы, а не её эффект.

Минимальная конфигурация — модель М1 (раздел 35.3)

Одно отделение на 20–35 жителей, одна смена-единомышленница, один приём пищи: два варианта второго блюда на обед, два-три дня в неделю, заказ накануне или на линии. Стандартный вариант гарантирован всегда.



----- первые примерно две недели после старта могут быть завышены самим наблюдением (эффект Хоторна) — рабочее допущение, а не измеренная величина

Пилот проверяет осуществимость и безопасность, а не эффект вариативности (раздел 35.4a).

Рисунок 8. Пилот на девяносто дней: две недели подготовки без изменений на линии, два месяца работы минимальной конфигурации М1, две недели оценки и одно письменное решение по светофору; три стоп-сигнала действуют в любой день (разделы 35.2–35.5)[42, 43]

Как читать числа пилота

Еженедельные числа удобнее смотреть не в таблице, а на графике хода процесса: по горизонтали недели или дни, по вертикали показатель, посередине линия медианы. Простые правила чтения таковы: сдвиг — шесть и более последовательных точек выше или ниже медианы; тренд — пять и более точек подряд, которые все растут или все снижаются; сам график лучше всего работает, когда в нём не меньше десяти точек[42]. За девяносто дней недельных точек набирается около тринадцати.

Справка. Почему график лучше двух чисел. Сравнение среднего «до» и среднего «после» скрывает время: оно не показывает, произошло ли изменение сразу после старта, постепенно или случайно в одну неделю. График хода процесса позволяет отличить настоящий сдвиг от обычного разброса без сложной математики. Это не статистическое доказательство эффекта, а способ не обмануться случайным колебанием.

Смещения нужно назвать вслух, иначе их назовут за вас. **Эффект Хоторна:** люди, знающие, что за ними наблюдают, ведут себя иначе; систематический обзор подтверждает, что такие эффекты существуют, но об их величине и длительности мало что известно достоверно[44]. Поэтому допущение, что две недели после старта завышены самим экспериментом, — рабочее правило, а не измеренная величина: база фиксируется до старта, выводы делаются по дням 30–90. Летние отходы нельзя переносить на зиму; при смене состава смены вы измеряете смену, а не вариативность; после особенно плохой недели следующая окажется лучше сама по себе — это возврат к среднему, и защита от него — семидневная база.

Что пилот доказывает и что нет

Пилот проверяет исполнимость и безопасность, а не эффект вариативности. Сравнение «до» и «после» на одном отделении без контрольной группы показывает, держатся ли два варианта в ритме смены, ведутся ли журналы, не выросли ли отказы и эпизоды аспирации и какова цена сырья, труда и отходов. Оно не показывает, что именно выбор улучшил отходы, вес или настроение: контролируемых исследований эффекта вариативного меню в психиатрии не опубликовано.

Решение удобно заранее записать в формате светофора, который методологи пилотных исследований считают предпочтительнее простого «стоп — продолжать»[43]; из их работы переносится только формат, а не пороги. **Зелёный:** журналы ведутся без срывов, выбор есть на большинстве приёмов, отказы и клинический риск не выросли, трудозатраты укладываются в смету — «умею безопасно», расширение или закрепление, но не «выбор доказал пользу». **Жёлтый:** исправимые проблемы с парами, потоком, очередью, маркировкой — ещё шестьдесят дней с исправлениями. **Красный:** рост отказов или аспираций либо неподъёмные трудозатраты — свёртывание приказом с причинами.

Немедленная остановка наступает при любом из трёх сигналов: рост отказов от еды в точке пилота, санитарные нарушения на новой линии, клинические противопоказания, выявленные врачом. Всё остальное — рабочие проблемы: очередь решается организацией потока, страхи персонала — инструктажем, жалобы «выбирают не то» — пересмотром пар.

Четыре исхода, которые надо знать заранее

Тихая смерть: к шестидесятому дню журналы перестают вестись, потому что у ритма нет владельца. **Бунт кухни:** второй вариант невыполним из-за загрузки плит, потому что пилот проектировали без заведующего производством. **Фиктивное оживление:** журналы заполнены, а

жители молчат, потому что журналы предзаполняют. **Честное свёртывание:** отказы выросли или трудозатраты неподъёмны, и пилот свёрнут приказом. Из четырёх исходов только последний — успех управления: система узнала о себе правду и не заплатила за это здоровьем жителей.

Насколько типичны первые три, показывает британское исследование домов ухода: из семи внедрённых вмешательств через несколько лет продолжались лишь три, а устойчивость зависела от мониторинга результатов, преемственности кадров и видимой пользы[45]. Долю «выживших» на российские дома не переносят, но перечень факторов узнаваем.

После пилота и если кухня чужая

Пилот — первый квартал годовой карты, где каждый квартал ценен сам по себе: фундамент и пилот; расширение на все приёмы или соседнее отделение и запуск совета жителей; закупки под парные позиции и первый квартальный отчёт учредителю; решение о всём доме по данным трёх кварталов и публичный рассказ.

Если питание поставляет внешний исполнитель, пилот начинается не с кастрюли, а со спецификации. Вариативность на аутсорсинге — это восемь строк контракта: перечень как группы взаимозаменяемых позиций, пропорции по статистике выбора, строка выбора, строка замен, строка качества для текстур, строка приёмки, строка состава, строка отчётности. Исполнение передаётся подрядчику, ответственность — нет: контроль проб, бракераж при приёвке, текстуры и эскалация отказа остаются за домом. Публичных кейсов вариативности на аутсорсинге нет; это пробел в знаниях, а не доказательство невозможности.

Подробно: разделы 19, 20, 21, 35, 36, 42 полного тома.

6

Документы, проверяющий и ответственность директора

Двенадцать документов — один пакет

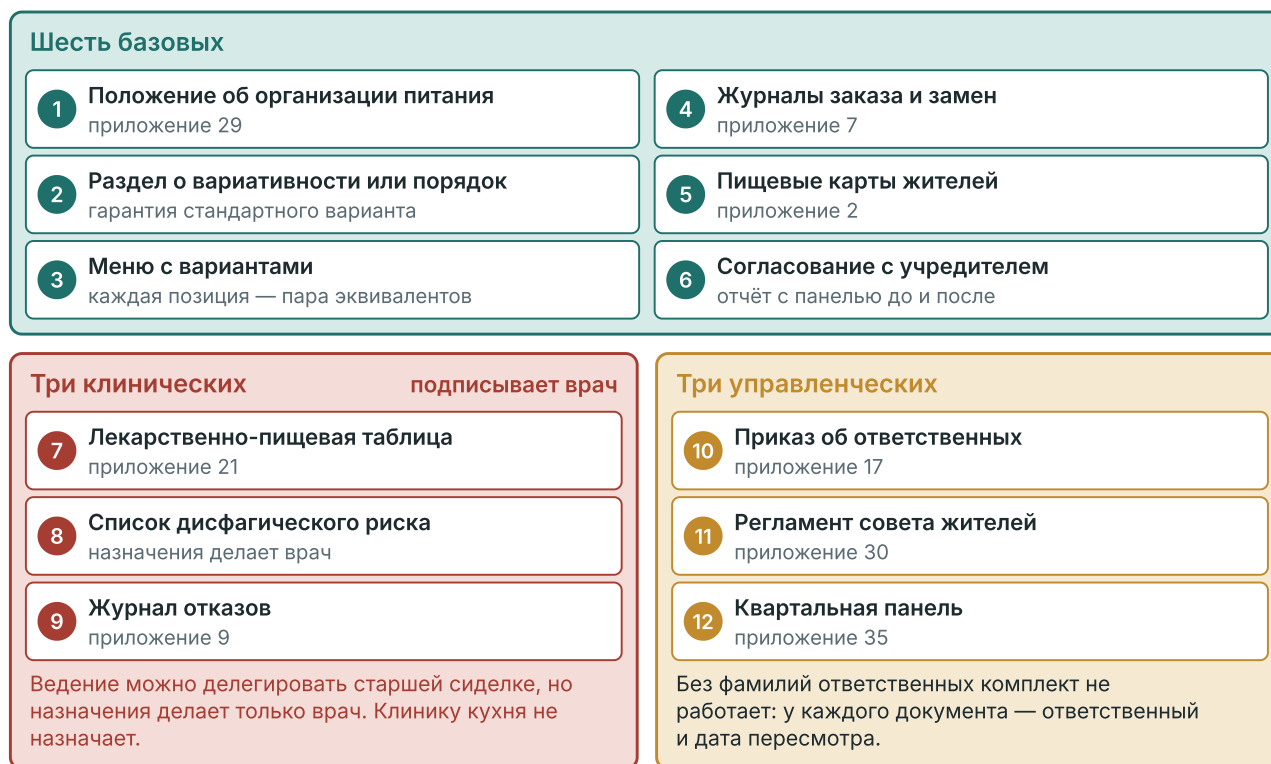
Практика, которая держится на людях, уходит вместе с ними. Комплект документов закрепляет границы, распределяет ответственность по фамилиям и делает практику воспроизводимой. Все шаблоны приложений полного тома — проекты локальных форм, а не нормативы и не «рекомендованные министерством образцы».

Шесть базовых документов. Положение об организации питания со ссылкой на закон № 3185-1, санитарные правила, нормы питания и обязательно на региональный акт, которым по новым Правилам организации деятельности устанавливаются нормы питания в организациях субъекта[40]. Раздел о вариативности с перечнем позиций, механизмом заказа, гарантией стандартного варианта — «никто не остаётся без полноценного приёма пищи» — и правилом замен; он может жить и в правилах внутреннего распорядка, как в Серафимовском[46], важно лишь, чтобы он был утверждён. Меню с вариантами, где каждая вариативная позиция — пара эквивалентов с обоснованием. Журналы заказа и замен. Пищевые карты жителей. Согласование с учредителем.

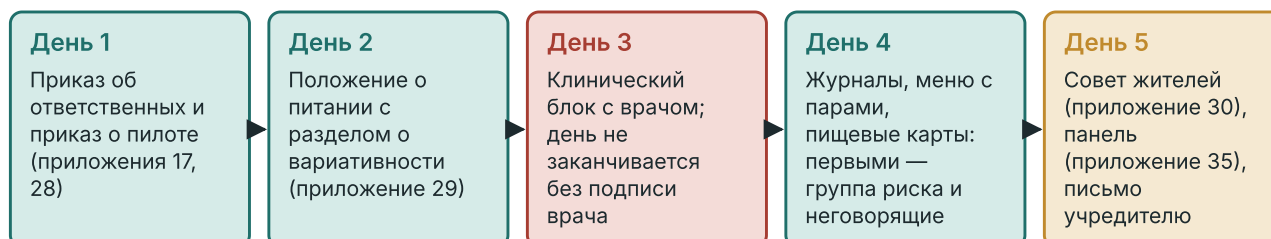
Три клинических документа. Лекарственно-пищевая таблица, подписанная врачом. Список дисфагического риска с назначенными текстурами. Журнал отказов с правилом трёх отказов.

Три управленческих документа. Приказ об ответственных — без фамилий комплект не работает. Регламент совета жителей по питанию. Квартальная панель показателей.

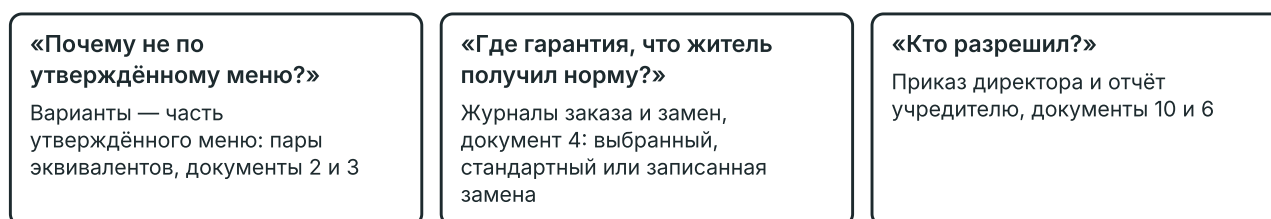
Двенадцать документов — один пакет, а не библиотека (разделы 31.2–31.4)



Сборка за пять рабочих дней, если заготовки приложений готовы (раздел 31.6)



Папка отвечает проверяющему бумагой на устный вопрос (раздел 32.3)



Проверка готовности: понимает ли новый сотрудник за час, что ему делать, и отвечает ли папка на три вопроса проверяющего? Если оба ответа «да», комплект работает.

Рисунок 9. Документальный комплект: шесть базовых, три клинических с подписью врача и три управленческих документа, которые собираются за пять рабочих дней и отвечают на три вопроса проверяющего (разделы 31.2–31.6, 32.3)

Если заготовки приложений готовы, комплект собирается за пять рабочих дней. День первый — приказы об ответственных и о пилоте. День второй — положение о питании с разделом о вариативности. День третий — клинический блок с врачом, и этот день не заканчивается без его подписи. День четвёртый — журналы, меню с парами и пищевые карты первой очереди: группа

риска и неговорящие жители. День пятый — регламент совета, панель, письмо учредителю. Проверка готовности — два вопроса: понимает ли новый сотрудник за час, что ему делать, и отвечает ли папка на три вопроса проверяющего.

Обратная опасность — раздувание. Каждая графа должна отвечать на вопрос «какое решение принимается по этой графе?»; графа, по которой решений не принимают, удаляется. У каждого документа есть и дата пересмотра: таблица врача — при каждой смене назначений, список риска — ежемесячно, положение — раз в год. Документ, который в живой системе год не менялся, либо мёртв, либо мертва сама система.

Кто приходит и о чём спрашивает

Роспотребнадзор проверяет санитарию: температуру, маркировку, суточные пробы, поточность. Вопросы «почему у вас два варианта» санитарный инспектор не задаёт, потому что ни одна редакция правил не ограничивает число блюд; отсюда правило — у каждой второй гастрорёмкости своя проба, своя строка в журнале и своя маркировка. **Контроль в сфере социального обслуживания и учредитель** смотрят на исполнение стандартов и нормативов, расходование средств, жалобы. **Прокуратура** приходит, как правило, по жалобе и спрашивает о правах жителей; журнал отказов и документированный выбор служат здесь ответом, а не уязвимостью.

Три вопроса и три ответа

«Почему не по утверждённому меню?» Варианты — часть утверждённого меню, а не отступление от него: пары нутриентно равноценны, перечень согласован. Здесь же проходит красная линия: если региональное меню императивно и исключает замены вне утверждённой таблицы, сначала меняется региональный документ, затем практика. Раздавать два варианта при императивном меню без изменения документа — нарушение, и полный том этого не советует.

«Где гарантия, что житель получил норму?» Журнал заказа и журнал замен: по ним видно, что каждый получил выбранный вариант, стандартный или зафиксированную замену. В России обязанность предложить альтернативу при отказе прямо не записана и выводится толкованием из права на достоинство[25]; журнал превращает это толкование в доказательство факта.

«Кто разрешил?» Приказ директора и отчёт учредителю. Учреждения, внедрившие выбор публично, шли именно этим путём.

На устный вопрос отвечают бумагой. Поэтому папка «Питание: проверки» собирается до старта пилота и хранится у заместителя, а не в сейфе: если её нельзя достать за минуту, её всё равно что нет. В ней десять разделов — приказы, положение, меню с парами, журналы за квартал, санитарный блок, клинический блок с подписью врача, панель, переписка с учредителем, протоколы совета жителей, последний акт проверки с отметками об устранении. Прошлогодние журналы хуже отсутствия папки: они показывают, что практика когда-то была, а теперь не ведётся.

Чего не говорить и как вести себя при проверке

Три фразы в коридоре звучат убедительно, а в акте становятся уликами. «Так теперь везде» — неправда и не аргумент. «Нам диетолог разрешил» — такой должности может не оказаться в штате, а клинические решения подписывает врач. «Жители сами захотели» без документа — непроверяемо; та же фраза со ссылкой на протокол совета становится доказательством.

При самой проверке достаточно пяти правил: отвечать на заданный вопрос; подтверждать факты документом; не спорить в коридоре, а излагать несогласие письменно; вести собственную запись хода проверки; не подписывать акт с непонятными формулировками без оговорки «с формулировкой не согласен, возражения будут представлены». Право сообщить контрольному органу о несогласии с результатами закреплено статьёй 36 закона № 248-ФЗ[47].

Если замечание всё же выписано, действуют по порядку: точно фиксируют формулировку, запрашивают норму, подключают учредителя на стадии возражения, помнят о сроках. Жалоба на решение или действие контрольного органа подаётся через Единый портал в течение тридцати календарных дней, на предписание — в течение десяти рабочих дней; рассматривается она пятнадцать рабочих дней[47]. На представление прокурора меры принимаются и сообщаются письменно в течение месяца[48]. Сроки указаны на дату проверки текста и перед подачей сверяются с действующей редакцией.

Ответственность: карта без запугивания

Публичные дела по статье 6.6 КоАП в учреждениях социального обслуживания известны, и все они касаются качества и достаточности питания, а не вариативности[6]. Санкция для должностных лиц — штраф от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических — от тридцати до пятидесяти тысяч или приостановление деятельности до девяноста суток[49]. Единственное найденное судебное толкование о применимости этой статьи вне общепита касается школы, а не дома-интерната: Верховный Суд переквалифицировал дело на статью 6.7, указав, что учреждение не является специализированной организацией, реализующей населению услуги питания[50]. Перенос этой логики на ДСО и ПНИ — аналогия и толкование, а не прямая позиция суда.

Уголовные составы формально применимы к руководителю, но требуют вины и последствий[51]; публичных уголовных дел против директоров ПНИ по организации питания не обнаружено. Запугивание ими — недостоверная риторика, игнорирование административного контура — легкомыслие. А «дел о двух вариантах не найдено» означает не «низкий риск», а непроверенную зону.

Главное: **вариативность не добавляет новых составов**, а перераспределяет жалобу: «невкусно» превращается в «я выбрал сам», но только если выбор задокументирован. Без документов два варианта читаются как отступление от меню, замена без записи — как «не докормили». Директор отвечает за систему контроля, а не за каждое событие за столом[6, 50]. Личный риск снижают четыре вещи: коллегиальность решения (приказ, протокол совета, уведомление учредителя), подпись врача под каждым клиническим документом, скорость разбора жалоб — в дни, а не в недели, и честность статусов: документ, названный проектом локальной формы, не даёт повода для претензии в самоуправстве. Риск определяется качеством следа, а не смелостью изменений.

Совет жителей

Совет жителей — организационная форма, в которой права становятся ежемесячной процедурой. Федеральной нормы о нём нет, он создаётся локальным актом; попечительский совет, состоящий из внешних лиц, его не заменяет, потому что в нём нет тех, кто ест. Работающий совет — пять–девять человек с квотами по отделениям, четыре полномочия (обсуждать меню до утверждения, проводить дегустации, собирать пожелания, получать ответ в срок) и ежемесячный протокол, который становится доказательством для проверяющего. Недееспособные жители участвуют через доверенных лиц и наблюдательные методы. Декоративный совет хуже отсутствующего: он производит цинизм.

Подробно: разделы 31, 32, 33, 34 полного тома.

7

Сколько это стоит и как это измерять

Честная рамка

Формула «вариативность почти бесплатна» из прежних версий удалена как недоказанная. Источники расходятся: одни пишут, что выбор реализуем без существенного роста затрат, другие — что вариативное меню объективно дороже единого из-за запаса, планирования и отходов при ошибках прогноза. Обе позиции имеют основания. Позиция доклада: модели М1–М2 при парах эквивалентов не требуют новых денег на сырьё, но требуют труда, планирования и точного учёта выбора, без которых действительно становятся дороже. И есть прямое свидетельство обратного «бесплатности»: старт в Серафимовском потребовал оборудования и дополнительных ставок[52]. Пилот модели М1 в одном отделении обычно укладывается в текущую смету; «без новой сметы» не значит «без затрат».

Три стоимости, которые путают

Справка. Сырьевая строка и полная стоимость. Сырьевой строкой в докладе называют стоимость продуктов на жителя в день; в зарубежной литературе это raw food cost. Полная стоимость питания включает также труд кухни, энергию, оборудование и амортизацию. В российских сметах полную стоимость отдельной строкой обычно не выделяют, а ближайший аналог сырьевой строки — стоимость набора продуктов по нормам, которые устанавливаются региональными актами[40].

Сырьевая строка — продукты на жителя в день. **Полная стоимость приёма пищи** — сырьё плюс труд, энергия и амортизация; по канадскому руководству она в три–шесть раз выше сырьевой строки[39], а аудит Онтарио при сырье 9,54 доллара оценил совокупные расходы на питание в 25,31 доллара на жителя в день[53]. **Стоимость кормления** — время помощников за столом, самая дорогая и самая скрытая строка, которая живёт в штатном расписании, а не в продуктовом бюджете. Отсюда главный экономический вывод: сокращение сырьевой строки — самая заметная и самая вредная экономия. Она бьёт прямо по жителям, экономит меньшую долю расходов и порождает скрытые издержки — потерю веса, болезни, жалобы, проверки. Эффективность разумно искать в большой доле: потоке раздачи, трудозатратах, отходах.

Три стоимости питания, которые путают (раздел 29.2)

Аудит Онтарิโอ, долларов на жителя в день: сырьё 9,54 из 25,31 полной стоимости

Сырьевая строка
продукты: 9,54

Полная стоимость: 25,31
+ труд кухни, энергия, оборудование, амортизация

По канадскому руководству полная стоимость в 3–6 раз выше сырьевой строки.

Стоимость кормления — самая дорогая и самая скрытая строка

Время помощников за столом: до 45 минут в день на жителя, которому нужна помощь (канадские данные). Живёт в штатном расписании, а не в продуктовом бюджете (разделы 28.3, 28.11).

Зарубежные суммы показывают механизм, а не норматив для России: свою строку дом считает сам (раздел 29.3).

Из чего складывается цена выбора при M1–M2 и парах эквивалентов (раздел 29.4)

Сырьё: около нуля

Не добавляется, а перераспределяется внутри той же строки: гречка или рис — расход круп прежний, меняется пропорция

Труд: минуты

Время раздачи и учёта на линии; повар — 10–20 минут на партию второго варианта; диетсестра — 4–8 часов раз в квартал; врач — диетические столы

Разовые затраты

Вторая гастрорёмкость, маркеры, визуальное меню

Ошибка прогноза

Излишек одного варианта уходит в бак, нехватка оборачивается заменой и недовольством; цену ошибки снижает только журнал заказа (раздел 21)

Модельные оценки, не замеры: фактическую цену даёт семидневный замер до старта и через 90 дней.

Калькулятор стоимости вариативности: четыре листа (приложение 42)

Лист 1. Пары блюд

Закладка, г × цена, руб./кг ÷ 1000 = стоимость порции; разница А и Б в месяц

Лист 2. Отходы

Остатки, г на порцию × число порций × цена; кухонные и тарелочные — раздельно

Лист 3. Сценарии

Снижение отходов на 10, 20, 30 % — гипотеза, а не прогноз

Лист 4. Два сценария

Собственный пищеблок или аутсорсинг: две позиции в задании (приложение 43)

Замер до и после — обязателен: калькулятор считает гипотезу, а не доказывает её

Отходы, г × цена килограмма по фактуре = рубли в бак. Снижение отходов подтверждает только повторный замер через 90 дней (приложение 25). С этими строками — разговор с учредителем (раздел 29.9).

Рисунок 10. Из чего складывается стоимость: сырьё — меньшая часть полной стоимости питания, помощь за столом — самая скрытая строка, а цена выбора при M1–M2 — это труд, разовые затраты и ошибка прогноза; калькулятор приложения 42 считает гипотезу, которую проверяет замер (разделы 29.2–29.4)[39, 53]

Как посчитать свою строку за час

Расходы на продукты за последний полный месяц делятся на число жителей и на число дней. Считают только продукты, без труда и коммунальных платежей; сравнивают себя с собой в динамике и с региональными коллегами, а не с зарубежными долларами; публикуют — учредителю и совету жителей. Во всех изученных странах перемены начинались с публикации сырьевой строки, и видимую строку сократить труднее, чем невидимую[54]. Если никто в доме не может назвать эту цифру за пять минут, это первая находка аудита.

Цена труда: минуты, а не страхи

Главный страх смены — «это добавит час на каждую раздачу». Иллюстративная раскладка полного тома для обеда на отделении из тридцати жителей в модели М1 даёт около **плюс двадцати четырёх человеко-минут** на обед: показ меню, сбор заказа, пересчёт объёмов, маркировка второй гастрорёмкости, раздача с предложением выбора, записи в журналы. При выборе в один приём два-три дня в неделю это порядка 50–70 человеко-минут в неделю на отделение. Оценка экспертная, опирается на канадские аналоги[39], и собственный замер обязателен. Её либо укладывают в пересменку, либо обосновывают ею заявку на ставку. Фраза «не справимся, потому что страшно» без цифры — не управление.

Отходы: единственная честная «экономия»

Несъеденная порция — оплаченное сырьё в баке. Выбор может снижать долю несъеденного, но доказательной базы такого эффекта в наших условиях нет. Ориентиры есть только в больницах, и переносятся они лишь как гипотеза. В обзоре 32 больничных исследований медиана отходов с тарелки составила 30 % по массе при разбросе от 6 до 65 %, а среди причин названы, в частности, неподходящие порции и ограниченный выбор[55]. В австралийской больнице переход к модели, при которой пациент сам заказывает блюдо, сопровождался снижением отходов с 30 до 17 % и годовых затрат на продукты на 28 %[56]; это ретроспективное сравнение в одной больнице, а больничный пациент и житель ПНИ — разные люди. Обещать учредителю экономию на основании зарубежных больничных данных нельзя.

Порядок действий прост: три блюда с наибольшими остатками убирают, уменьшают или заменяют парой, а массу недельных отходов умножают на цену килограмма по фактуре. Тарелочные остатки говорят о вкусе и порции, кухонные — о планировании, и смешивать их нельзя. Снижение отходов после введения выбора подтверждает только повторный замер через девяносто дней.

Измеряй факт, а не документ

Аудиторы Онтарио, побывавшие в часы еды в пятидесяти четырёх домах, увидели ожидание помощи и недоеденные тарелки, которых документы не показывали[53]: если питание не измеряется, разрыв между бумагой и тарелкой остаётся невидимым. Полный том предлагает три инструмента разной глубины.

Экспресс-аудит «Стол за один день» — двадцать четыре строки в четырёх блоках: до еды, во время еды, после еды, документы и люди. Проводит его не владелец процесса, а непрофильный сотрудник: заместитель по другому направлению, бухгалтер, сестра-хозяйка соседнего отделения, потому что своя столовая «всегда такая». Результат — зона, задающая первый шаг: 18–24 положительных ответа — удержание; 12–17 — сначала документы, линию не трогать; 6–11 — пилот, а не «всё сразу»; 0–5 — замеры и разговор с учредителем до любых изменений на линии. Зоны — рабочая конвенция доклада, а не валидированная шкала.

Семидневный замер — семь дней подряд трижды в день три веса: сколько выдано, сколько вернулось с тарелок, сколько осталось на кухне. Он повторяется ежеквартально, а выводы делают по повторяемости.

Квартальная панель — двенадцать чисел на одном листе. Из них пять стоит смотреть первыми.

Показатель	Как считать	Что он показывает
Ночной интервал	Часы от ужина до завтрака, по факту, а не по расписанию	Голод, который не лечит никакой выбор; рабочий ориентир — не больше 13 часов
Доля несъеденного	Семидневный замер: выдано, вернулось с тарелок, осталось на кухне	Вкус и порции (тарелки) и точность планирования (кухня)
Отказы и эскалация в срок	Число отказов и доля случаев, когда врач узнал в тот же день	Работает ли клинический контур, а не только журнал
Выбрали вариант Б и не получили	Доля от выбравших вариант Б	Реальность выбора; растёт — виноваты объёмы, а не жители
Сырьевая строка	Рубли на жителя в день за месяц	Финансовую прозрачность и ловушку экономии

Остальные семь строк панели — блюда-аутсайдеры, фактическое число кормимых на работника, температурная разница между линией и последним столом, соответствие текстур назначенным, весовые триггеры, доля актуальных пищевых карт, жалобы и ответы на них в срок. Весовые сигналы — две строки, а не одна: прибавка как сигнал метаболического риска и потеря как сигнал недостаточности питания; категорию риска присваивает медицинский работник, а не кухня.

Панель без плана на следующий квартал — отчёт; панель с тремя строками «что меняем» — инструмент управления. Кокрейновский обзор процедуры «аудит и обратная связь» показал небольшое или умеренное улучшение качества помощи, с медианой 2,7 %, и лучшие результаты там, где обратная связь сопровождается планом действий и исходит от уважаемого коллеги[57]. Данных о домах социального обслуживания в обзоре нет, но условия успеха подсказывают устройство панели.

Подробно: разделы 22, 28, 29 полного тома.

8

Учредитель и возражения

Почему разговор неизбежен

Большинство решений в домах упирается не в федеральный закон, а в региональный контур. Закон № 442-ФЗ относит к полномочиям субъекта утверждение норм питания, нормативов штатной численности и порядка предоставления социальных услуг[58]. Рамка, в которой живёт кухня, по закону задаётся в регионе, и вопрос «можно ли нам» директор задаёт тому, кто одновременно его финансирует и устанавливает для него правила. Просьба «можно ли нам» часто получает ответ «не надо»; вопрос, на который можно ответить документом, превращает разговор из просьбы в инженерную задачу.

Первая повестка: три вопроса

Из десяти вопросов полного тома на первую встречу выносят три.

Каков статус рекомендуемых норм приказа № 520н в нашем регионе: рекомендация или основа обязательного регионального норматива? От ответа зависит свобода манёвра при составлении пар[26].

Утверждено ли в регионе обязательное меню для организаций социального обслуживания и какова процедура внесения изменений? Если меню императивно, вариативность начинается с документа, а не с линии раздачи.

Согласен ли учредитель на пилот — одна точка, девяносто дней, панель показателей — с заранее оговорённой датой заслушивания? Просьба с датой — просьба о решении, а не о благословении, и на неё легче ответить «да».

Остальные вопросы подождут второй встречи. Отдельно стоит последний из десяти: что учредитель считает показателями качества питания. Сегодня в федеральном порядке независимой оценки качества условий оказания услуг отдельного показателя питания нет[59]; учредитель может включить долю выбирающих жителей и уровень отходов в свой мониторинг или государственное задание. Это толкование возможностей учредителя, а не обязанность, вытекающая из нормы.

Как вести разговор и что предложить взамен

Каждому вопросу нужна односторонняя справка, а ответы — письменно, хотя бы служебной запиской: позиция учредителя — половина защиты дома при проверке. О деньгах удобно говорить по скелету из десяти слайдов: сырьевая строка и её динамика, доля сырья в полной

стоимости, отходы в рублях по замеру, что сделано без денег, числа до и после, три позиции, которые стоят денег, цена бездействия, одно просимое решение с датой и что покажет отчётность через квартал. В разговоре о деньгах эмоция всегда проигрывает счёту.

Последний слайд воспроизводит австралийскую сделку. С 1 июля 2021 года учреждения там получают дополнительно 10 австралийских долларов в день на жителя при условии письменного обязательства обеспечивать питание надлежащего качества и ежеквартальной отчётности о расходах на продукты, работе кухни и специалистах по питанию[54, 60]. Такую же сделку может предложить российский директор: «дайте строку — я покажу, куда она пошла».

Если ответ «нет»

Отказ — не конец разговора, а диагностика, и с каждым уровнем отказа работают по-своему. **Ресурс** («нет денег») — список мер нулевой стоимости и замеры; деньги просят позже, под полученные цифры. **Риск** («накажут») — документы для проверяющего и старт без изменения линии: замеры, карты жителей, совет. **Статус** («не положено») — просьба назвать норму; часто нормы нет, и тогда «не положено» превращается в «не принято», а это уже разговор о решении. Отказ тоже получают письменно: через год рамка может смениться, и письменный отказ станет точкой отсчёта. Союзника же удерживают тремя вещами: отчётом числами, а не описанием активности, публичным признанием его роли и защитой документами того риска, который он на себя берёт.

Возражения и ответы

Почти в каждом возражении есть рациональное ядро — опасение за безопасность жителей, нагрузку персонала, деньги, исход проверки. Отвечать на него стоит по одной схеме: что в возражении верно, какой механизм снимает опасение и где собеседник может проверить ответ на собственных данных.

Справка. Почему отвечать замером, а не убеждением. В управленческом споре сталкиваются опыт («у нас так не получится») и чужой результат («у них получилось»). Ни то ни другое не переносится на конкретный дом автоматически. Третий вид знания — собственный замер до изменения и после него — единственный, который принимают обе стороны.

«Наши жители не способны выбирать». Часть жителей действительно не выбирает словами. Но у воли четыре канала — показ, наблюдение, биография, знание близких, — а там, где молчит и наблюдение, остаётся стандартный вариант. Австралийский Стандарт 6, действующий с 1 ноября 2025 года, требует, чтобы при каждом приёме пищи человек мог выбирать, «что, когда, где и как» он ест, а предпочтения оценивались у каждого[61]; формулы «независимо от когнитивного статуса» в нём при проверке не найдено.

«Будут очереди и хаос». Время на выбор реально. Поток решается конструкцией раздачи: заказом накануне, визуальным меню, которое житель видит до линии, маркировкой гастрорёмокостей. Успенский ПНИ сообщил, что страхи не подтвердились[19], но это сообщение учреждения, а не хронометраж; ответ о вашей линии даст только собственный замер времени раздачи.

«Это дорого». Неизвестно, пока не замерено. При парных эквивалентах сырьевая строка меняется мало, труд растёт на минуты, отходы могут снижаться. Утверждение «бесплатно» недоказано; против него — опыт Серафимовского[52].

«Санэпид не разрешит». Санитарные правила регулируют поточность, температуру, пробы и бракераж, но не число вариантов[23]. Замечание санитарного врача касается конкретного нарушения — температуры, пробы, маркировки, — и отвечать на него нужно конкретикой.

«Жители будут выбирать нездоровое». Пара эквивалентов — выбор внутри нормы, а не между нормой и вредом: «гречка или рис» не создаёт свободы «гречка или конфеты». Зерно правды в возражении есть: Серафимовский сообщил, что жители склонны выбирать популярное, а не самое полезное. Ответ — не запрет, а конструкция пар и пересчёт пропорций по статистике выбора.

«Лечебное питание несовместимо с выбором». Диета, назначенная врачом, задаёт множество допустимых блюд, а не одно блюдо; внутри этого множества составляются пары. Назначение диеты остаётся за врачом.

«Персонал против». Обычно персонал против не выбора, а непонятной надбавки к работе. Снимается это инструктажем, ролями в приказе и ритмом планёрок; главное — чтобы смена проектировала линию, а не узнавала о ней из приказа.

«Зачем, если и так нормально?» «Нормально» по чьим меркам? Семидневный замер отходов и журнал отказов за неделю покажут, насколько нормально на самом деле. Если окажется, что всё в порядке, дом получил инструмент проверки, и это тоже результат.

«Кухня не своя — выбирать не из чего». Без своей плиты директор меняет не кастрюлю, а спецификацию: восемь строк контракта и календарь правки технического задания.

Правое дело в зале губят три приёма: моральное превосходство (ответ словом «достоинство» на вопрос о деньгах звучит как «денег нет»), зарубежный аргумент без фильтра и обещание результата («отходы упадут на треть»). Рабочая формула ответа другая: принцип, метод проверки и чужой измеренный факт с указанием источника и границ. Она не требует от собеседника веры.

И последнее возражение, которое служит тестом на честность: «а сами бы вы так ели?». Руководство пробует еду с линии раздачи — с тарелки, а не из папки с раскладкой. Кто в этом месяце не ел ту еду, которую едят жители, не вправе спорить о её качестве. Стоит это ноль рублей.

Подробно: разделы 29.9, 37, 38 полного тома.

9

Что сделать в понедельник

Для первых шагов не нужны ни новая смета, ни изменение меню. Врач входит в рабочую группу, чтобы ставить границу, а не «назначать диету руками кухни».

1. **Посчитать сырьевую строку (один час).** Расходы на продукты за последний полный месяц разделить на число жителей и на число дней. Если за пять минут это число никто не назвал, это первая находка. Методика — приложение 25, раздел 29.3.
2. **Запустить семидневный замер (десять минут на запуск).** Ответственный — заведующий производством или старшая смены. Тарелочные остатки по трём приёмам, кухонные остатки, время от начала раздачи до последней тарелки, ночной интервал по факту — форма приложения 25; фактическое число кормимых на одного работника — форма приложения 26.
3. **Завести журнал отказов и объявить правило трёх отказов.** Каждый отказ записывается, при отказе предлагается альтернатива, три отказа подряд — врач в тот же день. Журнал — приложение 9, алгоритмы — приложения 10 и 11.
4. **Передать врачу клинический блок на подпись.** Лекарственно-пищевая таблица и список дисфагического риска по чек-листу медицинского контура (приложение 21), алгоритм при риске аспирации и удушья (приложение 12). Кухня не «убирает кофе сама».
5. **Издать приказ о рабочей группе (тридцать минут).** Директор или заместитель, врач или фельдшер, диетическая сестра или заведующий производством, старшая медицинская сестра одного отделения, по возможности представитель учредителя. Поручение — за тридцать дней подготовить предложение по пилоту на одном отделении на девяносто дней. Роли — матрица приложения 17.
6. **Направить учредителю письмо-уведомление (тридцать минут).** Одна страница: обоснование со ссылкой на опубликованные российские практики, ссылка на санитарные правила, сроки, просьба о согласовании или уведомительный порядок, три вопроса первой повестки. Шаблоны — приложения 33 и 44.
7. **Выбрать точку пилота с заведующим отделением (один час).** Отделение на 20–35 жителей, лучше «сложное», одна смена, один приём пищи — обед. Решение заносится в протокол группы; проект приказа о пилоте — приложение 28.
8. **Назначить непрофильного сотрудника на экспресс-аудит.** Двадцать четыре строки по чек-листам приложений 18–21 в случайный будний день; три вопроса о вчерашнем дне — по чек-листу проверки реальности выбора (приложение 24).
9. **Если кухня чужая — открыть контракт.** Найти строки выбора, замен, проб и отчётности; недостающее внести в график закупки по форме восьми строк (приложение 43).
10. **Пообедать с линии раздачи.** С тарелки, а не из папки с раскладкой; в ежемесячном чек-листе директора (приложение 18) это одна строка.

Чего не делать в первый понедельник. Не выбирать модель М1–М5: это решение группы после замера. Не менять меню. Не выпускать пресс-релиз. Совет жителей подключается позже, на этапе подбора пар эквивалентов, а опрос предпочтений по анкете в доступном формате (приложение 36) — во вторую неделю пилота.

Что будет на руках через семь дней: сырьевая строка, первая неделя замера, журнал отказов с подписью врача под клиническим блоком, приказ с пятью фамилиями, письмо учредителю, выбранное отделение и двадцать четыре строки аудита.

Последнее слово полного тома — не «внедряйте», а «измеряйте». Семь дней замера отделяют убеждение от знания. Из этого знания растут пилот, совет жителей, разговор с учредителем, а через год — рассказ, которому коллеги поверят, потому что за ним стоят ваши числа.

Подробно: разделы 4.2, 4.5, 31.6, 35.2, 43.4 полного тома.

Нумерация — по первому упоминанию в этой версии. Полный список литературы — раздел 44 полного тома.

1. Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 103н : зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2019 № 54588 : с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2020 № 617н. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-28.02.2019-N-103n/> (дата обращения: 09.10.2026).
2. Как устроены ПНИ в России : исследование. – Текст : электронный // Если быть точным : [сайт]. – 2026. – 9 апр. – URL: <https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym> (дата обращения: 09.10.2026).
3. Simmons, S. F. Prevention of unintentional weight loss in nursing home residents: a controlled trial of feeding assistance [Перевод заглавия: Профилактика непреднамеренной потери массы тела у проживающих домов престарелых: контролируемое исследование помощи при кормлении] / S. F. Simmons [et al.]. – Text : electronic // Journal of the American Geriatrics Society. – 2008. – Vol. 56, No. 8. – P. 1466–1473. – DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.01801.x. – URL: https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP20080817.html (дата обращения: 09.10.2026).
4. Hägg, S. [Влияние кофеина на фармакокинетику клозапина] / S. Hägg [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2000. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2014893/> (дата обращения: 09.10.2026).
5. Pillinger, T. [Прибавка массы тела на фоне антипсихотиков: метаанализ 100 рандомизированных контролируемых исследований] / T. Pillinger [et al.]. – Text : electronic // Lancet Psychiatry. – 2020. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31860457/> (дата обращения: 09.10.2026).
6. [Проверки прокуратуры по организации питания в учреждениях социального обслуживания]. – Текст : электронный // kashin.info : [сайт]. – URL: <https://www.kashin.info/prokuratura-informiruet/novosti-prokuratury/9121> (дата обращения: 23.07.2026).
7. [Питание]. – Текст : электронный // ДДСОЛ : [сайт]. – URL: <https://ddsol.ru/about/pitanie/> (дата обращения: 23.07.2026).
8. Font, L. [Дисфагия на фоне приёма антипсихотиков: распространённость : систематический обзор] / L. Font [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10455044/> (дата обращения: 09.10.2026).
9. Doan, T.-N. Prevalence and Methods for Assessment of Oropharyngeal Dysphagia in Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis [Перевод заглавия: Распространённость и методы оценки орофарингеальной дисфагии у пожилых людей: систематический обзор и метаанализ] / T.-N. Doan [et al.]. – Text : electronic // Journal of Clinical Medicine. – 2022. – Vol. 11, No. 9. – Art. 2605. – DOI: 10.3390/jcm11092605. – URL: <https://www.mdpi.com/2077-0383/11/9/2605> (дата обращения: 09.10.2026).
10. Correll, C. [Смертность при шизофрении: метаанализ] / C. Correll [et al.]. – Text : electronic // World Psychiatry. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9077617/> (дата обращения: 09.10.2026).
11. Luykx, J. J. Dopamine D2 receptor antagonism of antipsychotics and the risk of death due to choking [Перевод заглавия: Антагонизм антипсихотиков к дофаминовым D2-рецепторам и риск смерти от удушья] / J. J. Luykx [et al.]. – Text : electronic // Psychiatry Research. – 2024. – Vol. 339. – Art. 116012. – DOI: 10.1016/j.psychres.2024.116012. – URL: <https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/113463> (дата обращения: 09.10.2026).
12. O. Reg. 246/22: General [Перевод заглавия: Постановление Онтарио 246/22: общие положения] : under Fixing Long-Term Care Act, 2021 : ss. 75–80. – Text : electronic // Ontario.ca : [site]. – 2022. – URL: <https://www.ontario.ca/laws/regulation/220246> (дата обращения: 09.10.2026).
13. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Senioreneinrichtungen [Перевод заглавия: Стандарт качества DGE для питания в учреждениях для пожилых]. – Text : electronic // Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und

- Heimat : [site]. – URL: https://www.bmleh.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGE-Standard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (дата обращения: 09.10.2026).
14. [О нормах питания] : постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п : актуальная редакция. – Текст : электронный // ctonus.ru : [сайт]. – URL: https://ctonus.ru/f/normy_pitaniya.docx (дата обращения: 23.07.2026).
15. Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Псковской области : приказ Комитета по социальной защите Псковской области от 14.07.2020 № 206 ; [О нормах питания] : постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 607-п ; [О нормах питания] : постановление Правительства Ленинградской области № 458 ; О нормах питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационарной формах в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.08.2014 № 306-п. – Текст : непосредственный.
16. 42 CFR § 483.60. Food and nutrition services [Перевод заглавия: Свод федеральных нормативных актов США, раздел 42, § 483.60. Службы питания]. – Text : electronic // Legal Information Institute, Cornell Law School : [site]. – URL: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/42/483.60> (дата обращения: 09.10.2026).
17. Вариативное питание. – Текст : электронный // ГАУССО НСО «Болотнинский ПНИ» : [сайт]. – 2024. – 16 авг. – URL: <https://bpni.nso.ru/news/2312> (дата обращения: 09.10.2026).
18. Что за зверь такой? Вариативное питание. – Текст : электронный // ОГБУСО «Усть-Илимский дом социального обслуживания» : [сайт]. – 2024. – 27 сент. – URL: <https://ui-ogbuso.ru/novosti/> (дата обращения: 23.07.2026).
19. [Вариативное меню во всех отделениях]. – Текст : электронный // ГАУССО НСО «Успенский ПНИ» : [сайт]. – 2024. – 13 авг. – URL: <https://upni.nso.ru/news/1916> (дата обращения: 09.10.2026).
20. Вариативное питание в стационарных учреждениях социального обслуживания. – Текст : электронный // irkutsk.bezformata.com : [сайт]. – 2025. – 14 февр. – Пересказ публикации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. – URL: <https://irkutsk.bezformata.com/listnews/variativnoe/142531226/> (дата обращения: 09.10.2026).
21. Arnstein, S. R. A Ladder of Citizen Participation [Перевод заглавия: Лестница гражданского участия] / S. R. Arnstein. – Text : electronic // Journal of the American Institute of Planners. – 1969. – Vol. 35, No. 4. – P. 216–224. – DOI: 10.1080/01944366908977225. – URL: <https://www.maine.org/uploads/documents/ladder-of-citizen-participation.pdf> (дата обращения: 09.10.2026).
22. Abbey, K. L. Menu Planning in Residential Aged Care – The Level of Choice and Quality of Planning of Meals Available to Residents [Перевод заглавия: Планирование меню в домах престарелых: степень выбора и качество планирования блюд, доступных жителям] / K. L. Abbey, O. R. L. Wright, S. Capra. – Text : electronic // Nutrients. – 2015. – Vol. 7, No. 9. – P. 7580–7592. – DOI: 10.3390/nu7095354. – URL: <https://www.mdpi.com/2072-6643/7/9/5354> (дата обращения: 09.10.2026).
23. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения : СанПиН 2.3/2.4.4282-26 : утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 № 18 : зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2026 № 86854. – Взамен СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (действовали до 01.09.2026). – Текст : электронный // rovenkiadm.gosuslugi.ru : [сайт]. – URL: https://rovenkiadm.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/SanPiN_2.4.4282-26.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
24. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ : ст. 9, 16, 17, 31–34. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ (дата обращения: 09.10.2026).
25. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании : Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 : ст. 37, 39, 43, 44. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/ (дата обращения: 09.10.2026).
26. Об утверждении рекомендуемых норм питания... : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.09.2022 № 520н. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : [сайт]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405607433/> (дата обращения: 23.07.2026).
27. Конвенция о правах инвалидов : принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2006 г. : ст. 19, 25 (п. «f»), 28. – Текст : электронный // Организация Объединенных Наций : [сайт]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 09.10.2026).

28. О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ : ст. 10 «Специальные категории персональных данных». – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/ (дата обращения: 09.10.2026).
29. О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 : зарегистрирован в Минюсте России 12.09.2003 № 5073 : с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2024 № 70н. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44323/ (дата обращения: 19.08.2026).
30. Об утверждении норм лечебного питания : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.06.2013 № 395н : зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2013 № 28995 : с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2024 № 70н. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149196/ (дата обращения: 19.08.2026).
31. Bunn, D. K. Effectiveness of interventions to indirectly support food and drink intake in people with dementia: Eating and Drinking Well IN dementia (EDWINA) systematic review [Перевод заглавия: Эффективность вмешательств, косвенно поддерживающих потребление еды и питья людьми с деменцией: систематический обзор EDWINA] / D. K. Bunn [et al.]. – Text : electronic // BMC Geriatrics. – 2016. – Vol. 16. – Art. 89. – DOI: 10.1186/s12877-016-0256-8. – URL: <https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-016-0256-8> (дата обращения: 09.10.2026).
32. Wu, X. S. [Внедрение IDDSI: соответствие текстур стандарту] / X. S. Wu [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8994209/> (дата обращения: 09.10.2026).
33. Adult choking algorithm [Перевод заглавия: Алгоритм помощи взрослому при удушье инородным телом] / Resuscitation Council UK. – 2025. – URL: <https://www.resus.org.uk/sites/default/files/2025-10/Adult%20choking%20algorithm%202025%20.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
34. Об утверждении Порядка оказания первой помощи : приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.05.2024 № 220н : зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2024 № 78363 : вступил в силу 01.09.2024. – Текст : электронный // Новосибирский государственный технический университет : [сайт]. – URL: https://nstu.ru/static_files/63200/03.05.2024_220.pdf (дата обращения: 09.10.2026).
35. [Отравление литием: литий, натрий и водный режим]. – Text : electronic // Cleveland Clinic : [site]. – URL: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25207-lithium-toxicity> (дата обращения: 09.10.2026).
36. [Ингибиторы MAO: диетические ограничения (тирамин) : памятка для пациента]. – Text : electronic // NHS : torbayandsouthdevon.nhs.uk : [site]. – URL: <https://www.torbayandsouthdevon.nhs.uk/uploads/25672.pdf?last-updated=20201119> (дата обращения: 09.10.2026).
37. Garg, S. K. [Влияние грейпфрутового сока на фармакокинетику карбамазепина] / S. K. Garg [et al.]. – Text : electronic. – 1998. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9757152/> (дата обращения: 09.10.2026).
38. [Кофеин и клозапин: снижение концентрации клозапина при отмене кофеина : клинический обзор]. – Text : electronic // Pharmacy Times : [site]. – URL: <https://www.pharmacytimes.com/view/caffeine-and-clozapine> (дата обращения: 09.10.2026).
39. Best Practices for Nutrition, Food Service and Dining in Long Term Care Homes [Перевод заглавия: Лучшие практики питания, пищевого обслуживания и организации трапез в домах длительного ухода] / Dietitians of Canada. – 2019. – URL: <https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/2019-Best-Practices-for-Nutrition-Food-Service-and-Dining-in-Long-Term-Care-LTC-Homes.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
40. Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, рекомендуемых нормативов штатной численности и перечня оборудования... : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025 № 305н : зарегистрирован в Минюсте России 02.06.2025 № 82485 : вступает в силу 01.09.2025, действует до 01.09.2031. – Текст : электронный // pravo.ppt.ru : [сайт]. – URL: <https://pravo.ppt.ru/prikaz/mintrud/n-305n-314346> (дата обращения: 09.10.2026).
41. Proctor, E. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda [Перевод заглавия: Результаты исследований внедрения: концептуальные различия, трудности измерения и исследовательская повестка] / E. Proctor [et al.]. – Text : electronic // Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. – 2011. – Vol. 38, No. 2. – P. 65–76. – DOI: 10.1007/s10488-010-0319-7. – URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10488-010-0319-7> (дата обращения: 09.10.2026).

42. Run charts [Перевод заглавия: Графики серий] / Clinical Excellence Commission (NSW Health). – Text : electronic // CEC Academy. Quality improvement tools : [сайт]. – URL: <https://www.cec.health.nsw.gov.au/CEC-Academy/quality-improvement-tools/run-charts> (дата обращения: 09.10.2026).
43. Avery, K. N. L. Informing efficient randomised controlled trials: exploration of challenges in developing progression criteria for internal pilot studies [Перевод заглавия: К эффективным рандомизированным контролируемым исследованиям: трудности разработки критериев перехода для внутренних пилотных исследований] / K. N. L. Avery [et al.] ; Internal Pilot Trials Workshop members. – Text : electronic // BMJ Open. – 2017. – Vol. 7, No. 2. – Art. e013537. – URL: <https://bmjopen.bmj.com/content/7/2/e013537> (дата обращения: 09.10.2026).
44. McCambridge, J. Systematic review of the Hawthorne effect: new concepts are needed to study research participation effects [Перевод заглавия: Систематический обзор эффекта Хоторна: для изучения эффектов участия в исследовании нужны новые понятия] / J. McCambridge, J. Witton, D. R. Elbourne. – Text : electronic // Journal of Clinical Epidemiology. – 2014. – Vol. 67, No. 3. – P. 267–277. – DOI: 10.1016/j.jclinepi.2013.08.015. – URL: <https://researchonline.lshtm.ac.uk/1380017> (дата обращения: 09.10.2026).
45. Devi, R. Sustaining interventions in care homes initiated by quality improvement projects: a qualitative study [Перевод заглавия: Поддержание в домах ухода вмешательств, начатых проектами улучшения качества: качественное исследование] / R. Devi [et al.]. – Text : electronic // BMJ Quality & Safety. – 2023. – Vol. 32, No. 11. – P. 665–675. – DOI: 10.1136/bmjqs-2021-014345. – URL: <https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/183374/> (дата обращения: 09.10.2026).
46. Об утверждении правил внутреннего распорядка жителей СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» : приказ директора СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» от 10.03.2026 № 124. – Текст : электронный // СПб ГАСУСОН «ДСО «Серафимовский» : [сайт]. – URL: <https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/> (дата обращения: 21.08.2026). – Сайт прекратил работу; архивная копия: <https://web.archive.org/web/20260415001233/https://www.pni9.ru/правила-внутреннего-распорядка/>.
47. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ : ст. 36, 40, 43, 88. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/ (дата обращения: 09.10.2026).
48. О прокуратуре Российской Федерации : Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 : ст. 24. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/zakon-o-prokurature/24/> (дата обращения: 09.10.2026).
49. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : ст. 3.4, 4.1.1, 6.6. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/koap/6.6/> (дата обращения: 09.10.2026).
50. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 21.02.2019 № 11-АД19-4. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ : [сайт]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72095418/> (дата обращения: 09.10.2026).
51. Уголовный кодекс Российской Федерации : ст. 238, 293. – Текст : электронный // zakonrf.info : [сайт]. – URL: <https://www.zakonrf.info/uk/293/> (дата обращения: 09.10.2026).
52. Работа по развитию психоневрологических интернатов продолжается. – Текст : электронный // Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга : [сайт]. – 2025. – 22 июля. – URL: <https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/302216/> (дата обращения: 17.08.2026).
53. Food and Nutrition in Long-Term-Care Homes : Value-for-Money Audit [Перевод заглавия: Питание в домах длительного ухода : аудит эффективности расходов] // Annual Report 2019 / Office of the Auditor General of Ontario. – Toronto, 2019. – Vol. 1, Chapter 3.05. – URL: https://www.auditor.on.ca/en/content/annualreports/arreports/en19/v1_305en19.pdf (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
54. Milte, R. [Исследование Foodservice Costing Tool: полная стоимость пищевой службы домов престарелых] / R. Milte [et al.]. – Text : electronic // PubMed Central. – 2022. – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9321358/> (дата обращения: 09.10.2026).
55. Williams, P. Plate waste in hospitals and strategies for change [Перевод заглавия: Несъеденная пища в больницах и стратегии изменений] / P. Williams, K. Walton. – Text : electronic // e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism. – 2011. – Vol. 6, No. 6. – P. e235–e241. – URL: https://ro.uow.edu.au/articles/journal_contribution/Plate_waste_in_hospitals_and_strategies_for_change/27740256 (дата обращения: 09.10.2026).
56. McCray, S. Room service in a public hospital improves nutritional intake and increases patient satisfaction while decreasing food waste and cost [Перевод заглавия: Обслуживание в палате по заказу в государственной больнице улучшает потребление пищи и удовлетворённость пациентов, снижая пищевые отходы и затраты] / S. McCray [et

- al.]. – Text : electronic // Journal of Human Nutrition and Dietetics. – 2018. – Vol. 31, No. 6. – P. 734–741. – DOI: 10.1111/jhn.12580. – URL: <https://research.bond.edu.au/en/publications/room-service-in-a-public-hospital-improves-nutritional-intake-and/> (дата обращения: 09.10.2026).
57. Ivers, N. Audit and feedback: effects on professional practice [Перевод заглавия: Аудит и обратная связь: влияние на профессиональную практику] / N. Ivers [et al.]. – Text : electronic // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2026. – Issue 6. – Art. No. CD000259. – Publ. 22 June 2026. – URL: https://www.cochrane.org/CD000259/EPOC_audit-and-feedback-effects-on-professional-practice-and-healthcare-outcomes (дата обращения: 09.10.2026).
58. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ : ст. 8 «Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания», пп. 5, 6, 10, 24.1. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/2a85900e96a4b07cbc892bd43e0be773fd1f102e/ (дата обращения: 09.10.2026).
59. Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н : зарегистрирован в Минюсте России 11.10.2018 № 52409. – Текст : электронный // rulaws.ru : [сайт]. – URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-31.05.2018-N-344n/> (дата обращения: 09.10.2026).
60. New Basic Daily Fee supplement [Перевод заглавия: Новая надбавка к базовому суточному сбору : форма обязательства и условия] / Australian Government, Department of Health. – 2021. – June. – URL: <https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2021/06/new-basic-daily-fee-supplement.pdf> (дата обращения: 09.10.2026). – Text : electronic.
61. Strengthened Aged Care Quality Standards. Standard 6: Food and Nutrition [Перевод заглавия: Усиленные стандарты качества ухода за пожилыми. Стандарт 6: Еда и питание] / Aged Care Quality and Safety Commission. – Text : electronic // Aged Care Quality and Safety Commission : [site]. – 2025. – URL: <https://www.agedcarequality.gov.au/providers/quality-standards/strengthened-aged-care-quality-standards> (дата обращения: 09.10.2026).